

Buku Referensi
**MANAJEMEN KEPERAWATAN
DALAM PERAWATAN PALIATIF**

Neni Nuraeni
Christina Yeni Kustanti
Lam Murni Br Sagala
Ratna Aryani
Yuliati

MANAJEMEN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PALIATIF

Neni Nuraeni, M.Kep., Ns. Sp. Kep. Mat

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D

Lam Murni Br Sagala, S.Kep., Ns., M.Kep

Ns. Ratna Aryani, M.Kep

Yuliati., SKp., MM., M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PALIATIF

Penulis: Neni Nuraeni, M.Kep., Ns., Sp.Kep. Mat
Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D
Lam Murni Br Sagala, S.Kep., Ns., M.Kep
Ns. Ratna Aryani, M.Kep
Yuliati, SKp., MM., M.Kep

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN : 978-623-10-9583-1

Cetakan Pertama : Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang berjudul **Manajemen Keperawatan dalam Perawatan Paliatif** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam bidang perawatan paliatif yang semakin penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Perawatan paliatif merupakan pendekatan holistik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa, serta keluarganya, melalui pencegahan dan peredaan penderitaan sejak dini, dengan identifikasi, asesmen, dan pengelolaan nyeri serta masalah fisik, psikososial, dan spiritual lainnya. Dalam konteks ini, peran perawat menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pendamping yang empatik dan komunikatif.

Buku ini membahas lima topik utama yang dirancang untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan perawat dalam memberikan perawatan paliatif secara komprehensif. Topik pertama mengulas peran keperawatan dalam memberikan perawatan paliatif, mencakup fungsi perawat dalam tim multidisiplin dan tanggung jawab profesional dalam mendukung pasien dan keluarga. Topik kedua membahas pendekatan komunikasi yang efektif dengan pasien paliatif, yang merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan saling percaya dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.

Selanjutnya, topik ketiga menyentuh dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif, karena keluarga juga menjadi bagian yang terdampak dan memerlukan perhatian khusus. Topik keempat menjelaskan pengelolaan nyeri pada pasien dengan penyakit terminal, sebagai salah satu aspek klinis utama dalam perawatan paliatif. Terakhir, buku ini mengupas edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan paliatif di rumah, yang penting dalam memastikan kontinuitas perawatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien di lingkungan yang lebih nyaman.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan, serta pihak lain yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan. Semoga buku ini dapat mendorong penguatan peran keperawatan dalam sistem perawatan paliatif di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN PALIATIF... 1	
A.Pendahuluan.....	1
B.Peran Perawat Paliatif	2
C.Manajemen Nyeri dan Gejala	3
D.Komunikasi	6
E.Advokasi.....	12
F. <i>Nurse-led Palliative Care</i>	14
G.Tantangan Pelaksanaan Peran Perawat Paliatif.....	17
H.Penutup.....	20
Referensi.....	21
BAB II PENDEKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PASIEN PALIATIF	26
A.Pendahuluan.....	26
B.Prinsip Komunikasi Paliatif	26
C.Strategi Komunikasi Efektif dengan Pasien Paliatif	32
D.Tantangan dalam Komunikasi dengan Pasien Paliatif.....	34
E.Penutup	37
Referensi.....	38
BAB III DUKUNGAN PSIKOLOGIS BAGI KELUARGA PASIEN PALIATIF	39
A.Pendahuluan.....	39
B.Kebutuhan terhadap perawatan paliatif	41
C.Peran keluarga dalam perawatan paliatif	43
D.Dampak emosional & psikologis bagi keluarga pasien paliatif.....	45
E.Kebutuhan Keluarga dengan Pasien Paliatif.....	46
F.Strategi Pemberian Dukungan untuk Keluarga Pasien Paliatif.....	48
G.....Peran perawat dalam memberikan dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif	50
H.Membangun resiliensi pada keluarga dengan pasien paliatif	53
I.Penutup	54
Referensi.....	55
BAB IV PENGELOLAAN NYERI PADA PASIEN PENYAKIT TERMINAL.....	60
A.Pendahuluan.....	60
B.Penyakit Terminal/Illess Terminal	60

C.Nyeri pada Penyakit Terminal	61
D.Pengkajian Nyeri	62
E.Pengukuran Nyeri.....	62
F.Pengelolaan Nyeri pada Penyakit Terminal.....	63
G.Pengelolaan Nyeri Non Farmakologi.....	63
H.Penutup.....	65
Referensi.....	66
BAB V EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG PERAWATAN PALIATIF DI RUMAH.....	67
A.Pendahuluan.....	67
B.Perawatan Paliatif Dan Keluarga	68
C.Edukasi Dalam Perawatan Paliatif	70
D.Penutup	73
Referensi.....	75
Profil Penulis.....	79
Sinopsis Buku	82

BAB I

PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN PALIATIF

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif adalah bidang khusus dalam layanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu yang menghadapi penyakit serius dan mengancam jiwa (WHO, 2020). Berbeda dengan pengobatan kuratif yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, perawatan paliatif lebih mengutamakan manajemen gejala, menurunkan keluhan nyeri, dukungan emosional, dan kesejahteraan holistik. Perawatan ini dapat diberikan pada setiap tahap penyakit dan dapat dilakukan bersamaan dengan pengobatan kuratif, atau sebagai pendekatan utama ketika pemulihan tidak lagi memungkinkan. Artinya, perawatan paliatif dapat selalu diberikan dengan porsi yang menyesuaikan dengan perkembangan penyakit dan respon individu terhadap penyakitnya tersebut. Bentuk perawatan ini tidak hanya menangani aspek fisik dari penyakit, tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual individu serta keluarga mereka.

Dibandingkan dengan bidang layanan kesehatan lainnya, perawatan paliatif memiliki karakteristik unik, karena lebih menekankan kenyamanan daripada penyembuhan. Pada perawatan akut dan kritis, pelayanan berfokus pada intervensi agresif untuk memperpanjang hidup, sedangkan perawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan mempertahankan martabat pasien, terlepas dari prognosisnya. Pendekatan ini melibatkan kerja sama tim multidisiplin, dimana tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu atau profesi bekerja bersama untuk memberikan dukungan yang menyeluruh bagi pasien. Selain itu, perawatan paliatif juga mencakup dukungan bagi keluarga pasien, serta memberikan bimbingan dan bantuan dalam menghadapi dampak emosional dan sosial dari penyakit yang dialami oleh orang tercinta. Pendekatan yang holistik dan berpusat pada pasien ini membedakan perawatan paliatif dari pengobatan medis konvensional yang terutama berfokus pada manajemen penyakit.

Kenyataannya, terdapat sekitar 80% pasien yang meninggal membutuhkan perawatan paliatif, namun hanya setengah dari pasien yang dirawat di rumah sakit mendapatkan perawatan paliatif yang mereka butuhkan (Murtagh et al., 2014). Oleh karena itu, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan paliatif,

terutama menjadi penyedia utama dukungan yang penuh kasih dan berkelanjutan. Perawat bertanggung jawab dalam manajemen gejala, pemberian obat, edukasi bagi pasien dan keluarga, serta memberikan kenyamanan emosional dan psikologis. Selain tugas klinis mereka, perawat paliatif juga berperan sebagai advokat bagi pasien, memastikan bahwa preferensi dan tujuan perawatan pasien dihormati. Kehadiran perawat di sisi pasien, dikombinasikan dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang penuh kepercayaan, menjadikan perawat merupakan elemen yang tak tergantikan dalam pemberian perawatan paliatif yang berkualitas tinggi.

Bab ini akan membahas peran penting perawat dalam perawatan paliatif, dengan menyoroti kontribusi mereka dalam berbagai aspek dukungan pasien. Pembahasan akan mencakup tanggung jawab perawat dalam manajemen gejala, perawatan psikososial, pengambilan keputusan etis, dan kolaborasi antarprofesi. Selain itu, bab ini juga akan mengulas tantangan yang dihadapi perawat dalam bidang ini serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan paliatif yang efektif.

B. Peran Perawat Paliatif

Tanggung jawab profesional perawat dalam memberikan perawatan paliatif berakar kuat pada prinsip-prinsip inti praktik keperawatan dan didukung oleh pedoman etika yang ditetapkan oleh berbagai organisasi keperawatan nasional dan internasional. Perawatan paliatif maupun keperawatan secara umum menekankan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien, dengan memperhatikan kebutuhan holistik individu serta pengasuh keluarga (*caregiver*) mereka, termasuk dalam penilaian dan manajemen kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual. Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi perubahan status kesehatan pasien, sering kali menjadi fasilitator utama dalam memperkenalkan perawatan paliatif saat dibutuhkan. Meskipun perawatan paliatif mencakup berbagai kompetensi keperawatan, semua perawat berkontribusi secara signifikan dalam aspek utamanya, termasuk manajemen gejala, komunikasi yang efektif, dan advokasi bagi pasien (Hagan et al., 2018). Ketiga hal tersebut merupakan peran utama yang harus dilaksanakan oleh perawat di área keperawatan paliatif, diantara berbagai peran lainnya yang secara umum sudah dilaksanakan di área pelayanan keperawatan. Ketiganya akan diuraikan pada bagian berikutnya dari bab ini.

C. Manajemen Nyeri dan Gejala

Perawatan paliatif memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan individu dengan penyakit yang membatasi kehidupan, di mana manajemen nyeri menjadi salah satu komponen utama dari pendekatan khusus ini (Alghamdi et al., 2023). Nyeri didefinisikan sebagai “Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau potensial, atau yang dideskripsikan dalam istilah kerusakan tersebut” (St Marie, 2013). Memahami berbagai jenis nyeri, mulai dari nyeri nosiseptif hingga neuropatik, sangat penting untuk menilai dan mengelola nyeri secara efektif dalam konteks perawatan paliatif.

1. Nyeri somatik berasal dari aktivitas nosiseptif di kulit, jaringan subkutan, tulang, otot, dan pembuluh darah. Stimulus nyeri mengaktifkan serabut A-delta dan dengan cepat merambat melalui sistem saraf perifer dan pusat. Nyeri ini terlokalisasi dan digambarkan sebagai tajam, nyeri tumpul, atau berdenyut.
2. Nyeri visceral terjadi pada organ dalam dan rongga tubuh, serta ditransmisikan melalui serabut C. Nyeri ini lebih menyebar dan digambarkan sebagai nyeri yang menusuk, kram, tumpul, atau nyeri pegal.
3. Nyeri neuropatik muncul sebagai akibat langsung dari lesi atau penyakit yang memengaruhi sistem somatosensori. Nyeri ini biasanya mengikuti distribusi regional sesuai dengan persarafan perifer, lesi, atau penyakit yang memengaruhi sistem saraf perifer atau pusat. Tanda-tanda neurologis yang sesuai dengan distribusi nyeri dapat dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium atau objektif. Pasien dapat menggambarkan nyeri ini sebagai sensasi terbakar, kesemutan, tertusuk, atau mengalami sensasi yang tidak biasa, mulai dari mati rasa hingga sensasi seperti tersayat.

Berbagai *tool* atau instrumen telah dikembangkan bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan pengkajian nyeri dengan lebih baik, diantaranya adalah:

1. Brief Pain Inventory <http://medicine.iupui.edu/RHEU/Physicians/bpisf.pdf>
2. McGill Pain Questionnaire
www.fcesoftware.com/images/16_McGill_Pain_Questionnaire.pdf
3. Multidimensional Objective Pain Assessment Tool (MOPAT)
<http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC3114254/pdf/jpm.2010.0302.pdf>
4. Pain Outcomes Questionnaire
www.midss.ie/sites/www.midss.ie/files/pain_outcomes_questionnaire_sf_rev_2.pdf

5. West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory

www.tac.vic.gov.au/media/upload/west_haven_yale_multidimensional_pain_inventory.pdf

Strategi keperawatan dalam mengatasi nyeri mengadopsi pendekatan komprehensif yang menargetkan baik sumber maupun aspek nyeri. Selain manajemen medikasi (pengobatan), termasuk penggunaan opioid dan pengobatan komplementer, intervensi non-farmakologis seperti terapi fisik, pijat, dan terapi musik juga digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pasien.

Manajemen nyeri yang efektif dalam perawatan paliatif bergantung pada penilaian berkelanjutan, kolaborasi antarprofesi, edukasi pasien, serta penanganan berbagai aspek fisik, emosional, dan psikologis dari nyeri. Perawat memiliki peran krusial tidak hanya dalam memberikan perawatan tetapi juga sebagai advokat bagi pasien, memastikan bahwa strategi manajemen nyeri menghormati otonomi pasien dan melibatkan pengambilan keputusan bersama. Kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai pertimbangan kompleks dalam pereda nyeri menunjukkan pentingnya peran perawat dalam memberikan perawatan yang penuh empati dan berpusat pada pasien.

Tujuan utama dalam pengobatan nyeri dan manajemen gejala adalah memastikan bahwa perawatan yang diberikan adalah efektif (sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien), efisien (disampaikan secara tepat waktu dan sesuai), serta aman (meminimalkan risiko seperti depresi pernapasan, menangani efek samping sejak dini, serta mempromosikan penyimpanan dan pembuangan obat yang aman) (Paice et al., 2018). Upaya kolaboratif antara pemimpin keperawatan dan pembuat kebijakan kesehatan telah menghasilkan kerangka strategis untuk meningkatkan manajemen nyeri dan gejala dalam perawatan paliatif primer.

Manajemen nyeri dan gejala yang efektif merupakan aspek fundamental dalam perawatan bagi individu dengan penyakit yang mengancam jiwa serta dalam mendukung keluarga mereka. Perawat di berbagai lingkungan layanan kesehatan memiliki peran krusial dalam memberikan perawatan yang esensial ini. Pengakuan global terhadap pentingnya peran perawat dalam perawatan paliatif telah mendorong berbagai inisiatif untuk memperkuat kontribusi mereka dalam manajemen nyeri dan gejala. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi keperawatan internasional dan asosiasi perawatan paliatif menekankan perlunya pendekatan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas serta aksesibilitas dalam perawatan gejala (Paice et al., 2018).

St Marie (2013) dalam artikelnya merangkum beberapa intervensi non-farmakologis yang dapat dipertimbangkan oleh perawat dalam manajemen nyeri atau keluhan lainnya, diantaranya adalah:

1. Relaksasi dapat dipelajari tetapi tidak dapat dipaksakan. Relaksasi melibatkan pelepasan pikiran yang penuh stres dan menggantinya dengan pikiran yang menyenangkan. Teknik relaksasi dapat membantu mengatasi nyeri akut, kronis, dan nyeri akibat kanker. Teknik relaksasi otot mencakup gerakan mengangkat bahu, memutar kepala, menggulung bahu, serta mengencangkan dan melemaskan lengan serta tangan. Teknik-teknik ini membantu memfokuskan pikiran dan sebaiknya dilakukan di ruangan yang tenang, nyaman, dan hangat.
2. Terapi panas dan dingin dengan menggunakan kompres hangat atau dingin efektif untuk mengatasi nyeri lokal. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya diketahui, panas diyakini meredakan nyeri dengan mengendurkan otot, sedangkan dingin membantu mengurangi pembengkakan. Pasien harus diberikan edukasi untuk melindungi kulit dari paparan panas atau dingin yang terlalu lama guna mencegah cedera jaringan.
3. Akupunktur adalah terapi dengan penempatan jarum di sepanjang sistem meridian tubuh. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa akupunktur merangsang pelepasan opioid endogen, yang menghasilkan efek analgesik. Standar pendidikan bagi praktisi akupunktur, baik dokter maupun non-dokter, ditetapkan oleh lembaga di tingkat negara bagian. Namun, cakupan biaya akupunktur dalam asuransi kesehatan bervariasi dan perlu dikonfirmasi untuk setiap pasien.
4. Refleksi diri memungkinkan pasien untuk mengenali dan menghormati perasaan mereka saat muncul. Kenangan atau pikiran yang menyakitkan dapat meningkatkan stres dan memperburuk nyeri. Mengubah (reframing) perasaan yang tidak nyaman dengan yang lebih menyenangkan dapat mengurangi stres dan mendukung relaksasi lebih lanjut. Kesehatan spiritual juga dapat menjadi aspek penting bagi pasien paliatif, dan dukungan terhadap aspek spiritual mereka dapat membantu dalam proses penyembuhan. Melalui spiritualitas, pasien dapat menemukan makna dalam penderitaan mereka dan dalam kehidupan mereka.
5. Pacing atau pengaturan ritmé aktivitas dilakukan dengan menyisipkan jeda singkat dan sering di antara aktivitas. Jeda ini memberi kesempatan bagi pasien untuk mengubah posisi, berlatih pernapasan dalam untuk relaksasi, meregangkan tubuh, serta menghindari rasa terburu-buru dan cemas dengan memperlambat tempo aktivitas. Konservasi energi merupakan bagian dari pacing dan dapat diajarkan kepada pasien serta pengasuhnya. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi nyeri pasien, tetapi juga gejala terkait lainnya seperti sesak napas (dispnea).

Melalui diskusi dan penelitian yang berkelanjutan, praktik terbaik dalam intervensi keperawatan telah dirumuskan guna mengoptimalkan hasil pasien. Upaya ini menyoroti pentingnya pendidikan yang komprehensif, perawatan klinis berbasis bukti, penelitian yang berkelanjutan, serta dukungan regulasi untuk meningkatkan praktik keperawatan paliatif di seluruh dunia (Paice et al., 2018). Integrasi berbagai aspek ini memastikan bahwa perawat memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani tantangan kompleks dalam manajemen nyeri dan gejala di berbagai sistem layanan kesehatan. Dengan memperkuat pendidikan keperawatan, kompetensi klinis, dan kolaborasi antarprofesi, sistem layanan kesehatan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi pasien dengan penyakit serius serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selain terkait nyeri, gejala lain yang perlu untuk dimonitor dan ditangani juga menyangkut keluhan psikologis atau emosional. Pada akhirnya, profesi keperawatan menjadi simbol perawatan yang penuh kasih dan berbasis bukti, yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup individu yang menghadapi penyakit serius. Seiring dengan berkembangnya perawatan paliatif, dedikasi dan keahlian perawat tetap menjadi elemen mendasar dalam memastikan manajemen nyeri yang holistik dan efektif.

D. Komunikasi

Perawatan paliatif harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan preferensi pasien serta keluarga mereka. Bagi banyak pasien dan keluarga, mempertahankan kendali atas perawatan merupakan hal yang penting. Tenaga kesehatan hanya dapat memberikan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat jika mereka memahami kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. Pasien dan keluarga harus yakin bahwa tujuan dan preferensi yang telah dibahas dengan tenaga kesehatan diketahui dan dihormati sepanjang proses perawatan. Hal ini memerlukan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya, karena kebutuhan, tujuan, dan preferensi dapat berubah seiring perjalanan penyakit (Engel et al., 2023).

Oleh karena itu, tenaga kesehatan dari berbagai disiplin dan profesi yang terlibat dalam perawatan paliatif, baik yang bersifat umum maupun spesialis, harus memiliki keterampilan komunikasi yang memadai. Pasien dan keluarga pada saat perawatan merupakan pihak yang cukup vulnerable. Perawatan pasien bisa menjadi suatu periode yang cukup membuat stress, sehingga komunikasi yang kurang baik dapat menjadikan stress yang dialami oleh pasien dan keluarganya menjadi

bertambah. Komunikasi yang efektif dari perawat di área perawatan paliatif berpotensi meningkatkan manajemen gejala pasien, mengurangi beban serta tekanan emosional bagi keluarga pengasuh, dan membantu proses penyesuaian dalam masa berduka (Ellington et al., 2012).

Pada bagian ini, komunikasi yang diutamakan adalah komunikasi secara umum antara tenaga kesehatan, khususnya perawat, dengan pasien dan keluarganya. Komunikasi breaking bad news merupakan wewenang dokter, tetapi perawat perlu untuk mengetahuinya. Hanya saja, komunikasi breaking bad news tersebut bukan menjadi fokus pembahasan pada bagian ini.

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Engel et al. (2023), terdapat tujuh tema utama komunikasi yang efektif berdasarkan persepsi pasien dan keluarganya:

1. Informasi yang terbuka dan jujur

Banyak pasien ingin mendapatkan informasi yang terbuka dan jujur tentang kondisi mereka, termasuk diagnosis, penyakit, kondisi kesehatan, pengobatan, efek samping, perkembangan penyakit (seperti metastasis), dan prognosis. Dalam beberapa penelitian, pasien juga menyatakan bahwa mereka menghargai jika hasil pemeriksaan diagnostik dapat diinformasikan dengan cepat.

Beberapa artikel membahas dampak komunikasi yang terbuka. Studi menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap komunikasi meningkat ketika mereka dapat berbicara secara terbuka mengenai detail penyakit, prognosis, atau proses kematian. Komunikasi yang terbuka juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pasien. Selain itu, beberapa pasien merasa lebih memiliki kendali dan rasa aman, dengan mendapatkan informasi yang cukup tentang pilihan pengobatan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih matang terkait perawatan mereka.

Hubungan antara komunikasi yang terbuka dan rasa aman juga terlihat dari pengalaman pasien yang merasa kurang mendapat informasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien merasa terisolasi ketika mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan informasi yang memadai. Pasien mengungkapkan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka membantu mereka lebih siap dalam mengambil keputusan yang tepat.

Dalam hal berbagi kebutuhan dan kekhawatiran, pengalaman serta kebutuhan keluarga pasien umumnya serupa dengan pasien itu sendiri. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi antara keluarga dan pasien. Meskipun keluarga juga bisa merasa sulit menerima informasi yang terbuka dan jujur serta mungkin tetap ingin berpegang pada harapan, mereka umumnya memiliki kebutuhan informasi yang lebih besar dibandingkan pasien.

Untuk dapat memberikan dukungan optimal dan mempersiapkan perawatan di masa depan, keluarga menyatakan bahwa mereka membutuhkan informasi prognostik yang tepat waktu dan rinci, serta pemahaman tentang proses menjelang kematian.

Tentu saja komunikasi yang terbuka dan jujur ini perlu dilakukan dengan sensitif. Tidak semua pasien, keluarga, dengan latar belakang mereka masing-masing, dapat menerima informasi secara terbuka dan jujur. Perawat perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu, siapa dan seberapa dalam informasi atau diskusi yang bisa dilakukan, jangan sampai informasi tersebut justru akan menambah stress psikologis pasien dan keluarganya. Pengkajian yang dimaksud adalah sejauh mana kesiapan pasien dan keluarganya dalam menerima atau memberikan informasi. Juga penting untuk mempersilahkan pasien atau keluarga untuk menyampaikan apa yang mereka pahami atau ketahui terlebih dahulu, untuk mengukur sejauh mana informasi perlu dan bisa diberikan.

“Tidak ada lagi hal yang dapat kita lakukan untuk pasien” adalah suatu contoh komunikasi yang sangat jujur dan terbuka, tetapi tidak sensitif. Seharusnya perawat atau tenaga kesehatan lain dapat lebih memilih kata-kata yang lebih netral, meskipun harus dijaga supaya tidak memberikan harapan yang berlebihan. Kalimat “Kondisi memang pasien kurang baik, tapi kita bisa melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi penderitaan dan meningkatkan kenyamanannya” mungkin lebih sensitif dibandingkan dengan kalimat pertama di awal alinea ini.

2. Menyesuaikan informasi dengan proses penerimaan dan pengelolaan

Meskipun banyak pasien menginginkan komunikasi yang terbuka dan jujur, banyak juga yang mengalami kesulitan dalam menghadapi informasi tentang memburuknya kondisi kesehatan mereka. Ada banyak momen krusial dalam perjalanan paliatif yang bisa terasa mengancam, seperti diagnosis penyakit serius, kegagalan pengobatan, transisi dari perawatan kuratif ke paliatif atau perawatan kenyamanan, serta perpindahan ke fasilitas perawatan lain.

Meskipun pasien menyatakan lebih memilih informasi yang terbuka mengenai hal-hal tersebut, informasi ini juga membuat mereka harus menghadapi kenyataan tentang kondisi yang semakin memburuk, berkurangnya pilihan pengobatan, meningkatnya ketergantungan, dan mendekatnya akhir kehidupan. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut, stres, dan gangguan eksistensial yang memicu ketidakpastian serta kehilangan kendali. Banyak pasien yang merasa siap menghadapi akhir hidup mereka dan keputusan yang

menyertainya, tetapi ketika benar-benar harus menghadapinya, mereka merasakan betapa beratnya hal tersebut.

Terdapat ketegangan antara keinginan untuk mendapat informasi yang terbuka dan kebutuhan untuk merasa aman, dan setiap pasien serta keluarganya memiliki cara berbeda dalam menghadapi hal ini. Beberapa pasien terbuka terhadap informasi rinci tentang akhir hayat, sementara yang lain memilih untuk menghindari diskusi tentang prognosis atau perawatan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan berpusat pada pasien. Pasien sering kali lebih memilih dokter untuk menilai seberapa banyak informasi yang ingin mereka terima dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya.

Pasien dan keluarga juga sering kali merasa kesulitan untuk meminta informasi lebih lanjut. Mereka tidak selalu tahu pertanyaan apa yang harus diajukan dan merasa lebih nyaman jika secara eksplisit diundang untuk bertanya selama atau setelah percakapan dengan tenaga kesehatan. Pasien menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi yang diberikan dan menginginkan tenaga kesehatan memberi mereka ruang untuk itu serta mengakui penderitaan yang mereka alami. Sebagian besar pasien dan keluarga juga mengharapkan informasi disampaikan dengan penuh empati, mengingat dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh diagnosis atau prognosis terhadap kehidupan mereka.

Menyelaraskan informasi dengan proses yang sedang dijalani pasien, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka, serta memberikan ruang untuk pertanyaan merupakan strategi yang dianggap bermanfaat. Pasien dan keluarganya sering kali merasa bahwa setelah menerima berita buruk, dokter terlalu cepat beralih ke aspek positif atau langsung menawarkan pemeriksaan lain. Beberapa pasien bahkan merasa ditekan untuk segera mengambil keputusan terkait perawatan atau tidak menerima perawatan tertentu.

Pasien lebih menghargai jika tenaga kesehatan menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami dampak berita buruk tersebut terhadap kehidupan pasien. Mereka ingin dilihat sebagai individu, bukan sekadar sebagai penyakit yang harus ditangani. Beberapa pasien juga merasakan bahwa percakapan dengan dokter sering kali dibatasi oleh aturan, hanya berfokus pada gejala dan pengobatan, dengan sedikit ruang untuk membicarakan kematian yang semakin dekat. Keluarga dari seorang pasien di ICU pernah melakukan komplain karena dokter tidak memberikan informasi secara baik dengan mengatakan "Pasien sudah tua, wajar kalau banyak anggota tubuh yang sudah tidak berfungsi. Dinikmati saja" (sambil berjalan pergi). Tentu saja hal ini dapat menimbulkan

ketidakpuasan di kalangan keluarga. Seharusnya tenaga kesehatan mempunyai cukup waktu untuk mendengarkan. Pasien di área perawatan paliatif bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan keluarga (*family meeting*) atau sering juga disebut sebagai *advance care planning* (Martina et al., 2022), untuk bisa merencanakan perawatan akhir kehidupan yang diinginkan oleh pasien dan keluarganya.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pasien merasa penting untuk diberikan kesempatan melakukan tindak lanjut setelah percakapan, sehingga mereka memiliki waktu untuk mempertimbangkan informasi yang telah diterima dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut jika diperlukan.

3. Empati

Sebagian besar pasien dan keluarga mereka mengungkapkan kebutuhan akan komunikasi yang empatik. Pasien menekankan bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan keterampilan yang tepat serta empati dari tenaga kesehatan. Mereka menunjukkan bahwa empati tercermin dalam sikap dan perilaku tenaga kesehatan, yang terkadang tidak sepenuhnya bergantung pada isi pembicaraan yang disampaikan.

Bahasa tubuh yang menunjukkan kesibukan dari tenaga kesehatan dapat membuat pasien merasa diabaikan atau menjadi beban. Bagi sebagian besar pasien dan keluarga, aspek informatif dalam komunikasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari aspek empatik. Selain itu, pasien menghargai adanya kontinuitas dalam tenaga kesehatan yang merawat mereka, karena hal ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan tenaga medis yang menangani mereka.

Menyapa pasien dan jangan lupa keluarganya, setiap pagi mungkin, di sela-sela waktu serah terima jaga, adalah suatu interaksi yang sangat penting. Terkadang fokus semua pihak adalah kepada pasien dan kurang perhatian terhadap keluarganya atau pengasuh keluarga. Sapaan sederhana seperti “apakah ibu/bapak sudah mandi?” atau “pasien sudah sarapan, bagaimana dengan keluarga yang menunggu pasien di sini?” sepertinya adalah komunikasi yang sangat sederhana, tetapi bisa mendatangkan senyuman bagi keluarga karena merasa juga diperhatikan.

4. Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Baik pasien maupun keluarga mereka menginginkan informasi disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jika tenaga kesehatan menggunakan istilah yang samar atau menghindari kata-kata tertentu, seperti

tidak menyebutkan kata "kanker," hal ini dapat membuat pasien merasa tidak yakin atau terisolasi.

Bagi keluarga, bahasa yang tidak jelas dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian. Ketika mereka tidak dapat menafsirkan dengan baik maksud dari tenaga kesehatan, mereka bisa merasa kewalahan oleh keseriusan situasi yang dihadapi. Penggunaan eufemisme juga dapat menghambat pemahaman pasien dan keluarga mengenai kondisi pasien. Misalnya, istilah seperti "sakit parah" mungkin memberikan pemahaman yang terbatas tentang sisa waktu yang dimiliki pasien. Terkadang, isyarat dari tenaga kesehatan yang menunjukkan bahwa kematian pasien sudah dekat tidak selalu dipahami oleh keluarga. Contohnya, memindahkan pasien ke kamar perawatan tunggal di rumah sakit sering kali merupakan tanda bahwa pasien berada dalam kondisi kritis, tetapi keluarga mungkin tidak menyadari maknanya. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan bahasa yang jelas agar pasien dan keluarga memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyelesaikan hal-hal penting bersama.

5. Memberi ruang untuk strategi koping yang positif

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa baik pasien maupun keluarga mereka membutuhkan pemikiran positif dan harapan, selain informasi yang jujur. Banyak pasien dan keluarga merasa lebih tenang ketika dokter menunjukkan pemahaman bahwa mereka tetap berpegang pada hal-hal yang masih bermakna dalam hidup, meskipun menerima kabar buruk. Prinsip yang perlu selalu untuk dipegang adalah "*here*" dan "*now*", yaitu "di sini" dan "saat ini", yang bermakna bahwa terlepas dari dinamika kesehatan pasien, biarkan pasien dan keluarga hidup dengan sebaik-baiknya saat ini, bukan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Hal ini kembali pada esensi perawatan paliatif, yaitu mempertahankan kualitas hidup pasien, bahwa dia bisa hidup seoptimal mungkin "saat ini".

6. Profesional kesehatan yang berdedikasi dan bertanggung jawab

Keterlibatan banyak tenaga kesehatan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pasien dan keluarga mereka mengenai apakah ada seseorang yang benar-benar bertanggung jawab atas perawatan mereka. Hal ini dapat mengurangi rasa aman dan kepercayaan pasien, yaitu keyakinan bahwa mereka tidak hanya menerima perawatan medis yang baik, tetapi juga bahwa tenaga kesehatan peduli terhadap mereka sebagai individu.

Keberlanjutan tenaga kesehatan yang merawat pasien membantu menghindari keharusan menceritakan ulang kisah mereka berulang kali dan memfasilitasi hubungan manusiawi, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen tenaga kesehatan. Jika beberapa tenaga kesehatan terlibat, pasien menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaporan mengenai penyakit dan hasil tes mereka.

Selain itu, pasien dan keluarga lebih menyukai sikap proaktif dari tenaga kesehatan, kecuali jika pasien mengindikasikan sebaliknya.

7. Pengakuan terhadap peran keluarga sebagai pemberi perawatan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga sering kali menjadi tumpuan utama dukungan bagi pasien. Banyak anggota keluarga merasa terbebani secara emosional dan fisik serta menganggap bahwa peran mereka sebagai pemberi perawatan layak mendapat perhatian dan pengakuan dari tenaga kesehatan.

Pasien dan keluarga menekankan bahwa tenaga kesehatan sebaiknya meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan yang dipersonalisasi jika memungkinkan. Terkadang, anggota keluarga merasa perlu melindungi pasien dari informasi yang mengancam, seperti tentang prognosis, agar pasien tetap memiliki harapan dan tidak terlalu terbebani oleh kenyataan yang sulit. Hal ini terutama berlaku dalam budaya non-Barat, di mana anggota keluarga lebih memilih untuk menerima informasi secara jelas agar dapat merawat pasien dengan lebih baik. Sebagian keluarga juga menghindari mengajukan pertanyaan sendiri demi menghormati pasien yang mungkin tidak ingin mengetahui semua informasi. Sebaliknya, ada pasien yang memilih untuk tidak memberi tahu keluarga mereka tentang perkembangan penyakitnya, terutama jika kondisi memburuk dan dapat menambah beban atau kekhawatiran keluarga.

Kunci komunikasi yang terbuka terletak pada tenaga kesehatan, yang dapat menjadi contoh dalam menciptakan keterbukaan dan kepercayaan antara pasien dan keluarganya.

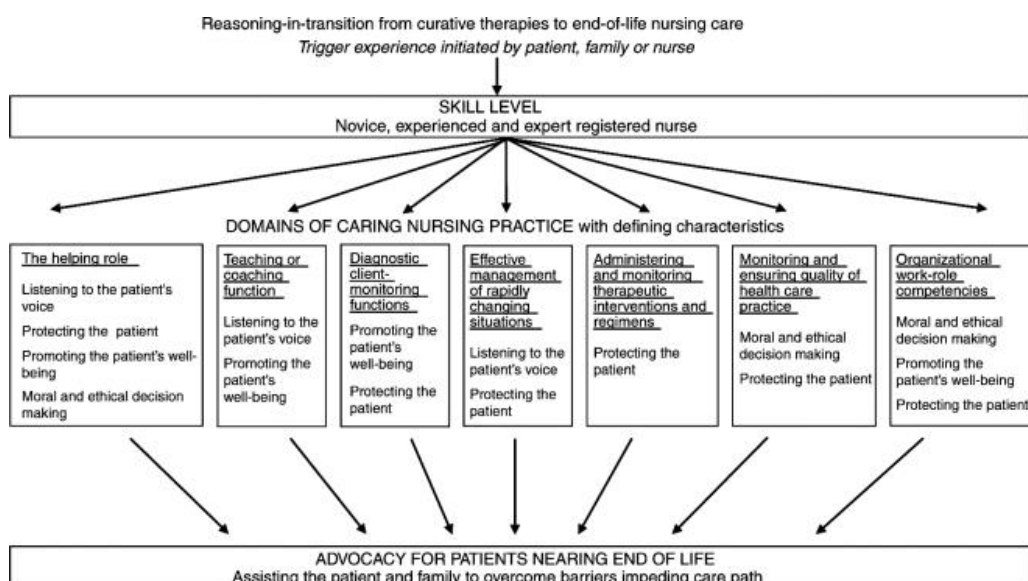
E. Advokasi

Meskipun seruan untuk integrasi dini perawatan paliatif telah menjadi standar perawatan, masih terdapat hambatan budaya dan praktik dalam memperkenalkan perawatan paliatif bagi pasien, pengasuh, dan klinisi. Mengenal pasien secara mendalam merupakan inti dari praktik keperawatan yang terampil, yang

meningkatkan kemampuan perawat dalam membangun hubungan positif, terlibat dalam praktik yang berbasis keahlian, serta membuka peluang untuk advokasi pasien (Hagan et al., 2018).

Perawat berada dalam posisi yang baik untuk mengadvokasi dan mendorong penggunaan perawatan paliatif di berbagai lingkungan layanan kesehatan. Sebagai advokat terlatih, perawat bekerja sama dalam tim interdisipliner untuk menyampaikan perspektif dan prioritas pasien. Keterampilan ini menjadi sangat penting ketika pasien menghadapi penyakit serius. Banyak pasien yang tidak mengetahui adanya pilihan perawatan lanjutan, dan perawat memiliki peran utama dalam mendiskusikan opsi perawatan paliatif serta menjelaskan bagaimana layanan ini dapat membantu mengatasi masalah medis, psikososial, dan logistik yang dihadapi pasien dan pengasuh. Sebagai anggota tim perawatan, perawat dapat memanfaatkan keterampilan komunikasi mereka untuk mengadvokasi kekhawatiran, kecemasan, dan prioritas pasien serta pengasuh dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan (Hagan et al., 2018).

Dalam gambar di bawah, Thacker menyajikan kerangka kerja Patricia Benner untuk membantu perawat menjadi advokat pasien yang efektif (Thacker, 2008). Perawat pemula mengandalkan aturan, kebijakan, dan prinsip konkret, sementara perawat yang telah berpengalaman mengembangkan proses berpikir yang lebih intuitif. Terdapat tujuh domain kepedulian dalam praktik profesional perawat menurut Benner, yaitu sebagai pendamping, pendidik, pendukung kesejahteraan pasien, pengelola perubahan cepat, pelindung pasien, pengambil keputusan moral dan etis, serta pengorganisir perawatan. Dua keterampilan penting yang harus dipelajari adalah mendengarkan secara aktif kepada pasien dan keluarga, serta mengomunikasikan perasaan mereka secara efektif kepada tim kesehatan lainnya.



Gambar 1. Konseptual model perilaku advokat dalam perawatan akhir kehidupan

Komunikasi mencakup pendokumentasian dalam rencana perawatan keperawatan dan rekam medis, serta diskusi verbal selama pergantian shift dan pertemuan tim multidisiplin. Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan percakapan mengenai arahan perawatan lanjutan, kurikulum sekolah keperawatan harus memasukkan pemahaman dasar ini, mengingat masih sedikitnya pembahasan tentang arahan perawatan lanjutan dalam buku teks dan kurikulum saat ini.

F. Nurse-led Palliative Care

Peran keperawatan telah dan terus menjadi bagian integral dalam pemberian perawatan paliatif. Sejak abad pertengahan hingga saat ini, ketika perawatan paliatif dan hospis berkembang dan akhirnya diakui sebagai praktik khusus, perawat telah merawat individu yang menghadapi penyakit serius dan mengancam jiwa. Esensi dari keperawatan berfokus pada perawatan holistik terhadap individu serta mendukung keluarga dalam menghadapi situasi sulit. Tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan klinis yang sangat baik, perawat juga harus memiliki keahlian dalam menangani aspek interpersonal serta membantu pasien dan keluarganya dalam mengambil keputusan penting terkait penyakit yang dihadapi. Berlandaskan kerangka etika yang kuat, perawat menghormati dan mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh pasien dan keluarganya (Fitch et al., 2015).

Saat ini, perawatan paliatif dapat diberikan di berbagai lingkungan layanan kesehatan, mencakup semua tahap penyakit serius (life-threatening illness), serta untuk individu dari segala usia beserta keluarganya. Perawatan paliatif juga tidak harus diberikan di unit khusus, melainkan di berbagai lingkup pelayanan keperawatan, mengingat belum semua rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan di Indonesia telah memiliki unit perawatan paliatif. Oleh karena itu, perawat dengan berbagai tingkat pendidikan dan keahlian turut berperan dalam pemberian perawatan paliatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, keberadaan dan nilai perawatan paliatif sering kali tidak diakui, terutama di lingkungan seperti unit gawat darurat, unit perawatan intensif, unit bersalin, panti jompo, dan lembaga perawatan jangka panjang (Fitch et al., 2015). Dengan adanya konsep perawatan paliatif terpadu yang diterapkan sejak awal perjalanan penyakit yang membatasi kehidupan, seluruh tenaga kesehatan, tanpa memandang lokasi

praktiknya, dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam perawatan paliatif.

Di banyak bagian dunia, perawat merupakan tenaga kesehatan utama sekaligus penghubung utama antara pasien, keluarga, dan anggota tim multidisiplin lainnya. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan bisa menjadi satu-satunya tenaga kesehatan yang terlihat di wilayah atau lingkungan tempat mereka bekerja. Meskipun perawat terlibat dalam peran kepemimpinan dalam perawatan paliatif melalui pendidikan, penelitian, manajemen, dan advokasi (pengembangan kebijakan), tugas utama mereka di seluruh dunia tetaplah memberikan perawatan paliatif secara langsung kepada individu dan keluarga (Fitch et al., 2015).

Sesuai dengan standar praktik profesional keperawatan yang diterima secara umum, dalam peran perawatan langsung kepada pasien, perawat bertanggung jawab untuk melakukan asesmen kesehatan secara menyeluruh, memberikan intervensi berbasis bukti, serta mengevaluasi dampak dari perawatan yang diberikan. Secara khusus, manajemen gejala, edukasi pasien, serta dukungan emosional bagi pasien dan keluarganya menjadi tanggung jawab utama. Tujuan perawatan harus disepakati secara bersama, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan preferensi, keinginan, dan nilai-nilai individu. Perkembangan menuju tujuan yang diharapkan dipantau secara ketat, dan setiap penyesuaian yang diperlukan dilakukan tepat waktu.

Kebutuhan unik setiap individu menjadi dasar dalam penyusunan rencana perawatan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, informasional, spiritual, finansial, dan praktis. Anggota keluarga serta orang-orang terdekat juga harus dimasukkan dalam rencana perawatan, karena kebutuhan mereka juga perlu diperhatikan. Selain itu, perhatian terhadap keluarga dalam masa berduka merupakan salah satu fokus tambahan bagi perawat, khususnya untuk perawat di area keperawatan komunitas. Perawat dapat turut membantu memonitor perilaku tidak wajar dari individu paska kehilangan, mengingat 9.8-49% keluarga yang berduka dapat mengalami duka yang patologis (Djelantik et al., 2020; Christina Yeni Kustanti et al., 2022; C. Y. Kustanti et al., 2022; Kustanti et al., 2023; Lundorff et al., 2017). Berbagai dukungan juga dapat disediakan untuk mencegah masalah psikologis yang lebih serius dari proses berduka (Kustanti et al., 2021). Pendekatan holistik dalam praktik keperawatan menjadi prinsip utama dalam kurikulum sekolah keperawatan dan sering kali disebut oleh banyak perawat sebagai filosofi yang membimbing mereka dalam memberikan perawatan setiap hari.

Peran baru seperti perawat spesialis klinis, perawat praktik lanjutan, navigator keperawatan, dan perawat dengan praktik tingkat lanjut mulai bermunculan dalam profesi ini dan semakin terlihat dalam praktik serta lingkungan perawatan

paliatif/hospice. Individu dalam peran ini dapat terlibat terutama dalam perawatan langsung kepada pasien, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan pendidikan dan penelitian. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa keahlian dalam perawatan paliatif tersedia bagi pasien serta anggota tim kesehatan lainnya. Selain itu, mereka diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka berperan sebagai agen perubahan dan mentor yang berupaya mencapai keunggulan dalam perawatan pasien.

Individu dalam peran ini sering kali menjadi penggerak dalam perancangan dan implementasi program baru untuk penyediaan layanan perawatan paliatif, terutama di komunitas, daerah pedesaan, dan wilayah terpencil. Kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam lingkup praktik yang lebih luas, serta keahlian dalam meresepkan dan menyesuaikan pengobatan, memungkinkan penyediaan perawatan paliatif di lokasi yang memiliki keterbatasan akses terhadap dukungan dokter. Solusi inovatif telah dikembangkan untuk menghubungkan praktisi dari daerah terpencil dengan dokter melalui telekonferensi, internet, dan komunikasi video daring. Pendekatan ini memungkinkan pasien tetap berada di komunitas mereka sendiri, dekat dengan keluarga dan jaringan dukungan mereka, sambil tetap mendapatkan akses ke keahlian perawatan paliatif yang diperlukan.

Komunitas keperawatan dalam perawatan paliatif telah menyuarakan dukungan terhadap konsep rujukan dini ke layanan paliatif dan, lebih baru lagi, penerapan filosofi perawatan paliatif sepanjang perjalanan penyakit serius atau yang mengancam jiwa (Hagan et al., 2018). Konsep rujukan dini telah lama muncul, terutama ketika layanan perawatan paliatif sering kali baru diberikan dalam beberapa hari terakhir kehidupan pasien. Dengan rujukan lebih awal, pasien memiliki lebih banyak waktu untuk menyusun rencana perawatan dan menyelesaikan berbagai kekhawatiran yang masih ada.

Pendekatan integrasi perawatan paliatif sepanjang perjalanan penyakit adalah konsep yang lebih baru dan menekankan pentingnya menerapkan prinsip serta filosofi perawatan paliatif sejak pasien pertama kali mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit yang membatasi kehidupan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen gejala, mendukung pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa preferensi pasien menjadi fokus utama sepanjang perjalanan penyakit mereka. Pendekatan ini muncul dari pemahaman bahwa tidak semua pasien memerlukan akses ke layanan paliatif khusus, tetapi tetap membutuhkan asesmen yang cermat, manajemen gejala yang tepat, serta perawatan dan dukungan yang berpusat pada individu oleh tim perawatan primer mereka. Meskipun ada dukungan terhadap pendekatan integratif dalam perawatan paliatif, perawat di

berbagai belahan dunia masih menghadapi tantangan dalam menerapkannya. Berbagai hambatan dan faktor eksternal memengaruhi pengalaman mereka dalam mencapai keberhasilan dalam perawatan paliatif yang terpadu.

Meskipun terdapat kesamaan antara perawatan paliatif dan keperawatan serta bukti manfaat perawatan paliatif yang dipimpin oleh perawat, masih ada berbagai hambatan di lingkungan klinis. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa asisten perawat bersertifikat, perawat praktik berlisensi, dan perawat terdaftar merasa nyaman dalam menilai gejala pasien, mereka melaporkan kurangnya pengetahuan tentang perawatan paliatif meskipun tetap terbuka untuk pelatihan. Misalnya, perawat sering menghadapi kesulitan dalam mendiskusikan prognosis dan perencanaan akhir hayat dengan pasien mereka.

Keengganan perawat untuk terlibat atau memimpin percakapan tentang perawatan paliatif mungkin berasal dari kurangnya kejelasan mengenai peran antarprofesional dan aspek perawatan paliatif yang berada dalam domain keperawatan. Jika perawat tidak merasa memiliki keterampilan dalam perawatan paliatif, mereka mungkin menyerahkan tanggung jawab mereka dalam menangani kebutuhan pasien, dengan asumsi bahwa anggota tim kesehatan lainnya akan memenuhi kebutuhan paliatif pasien. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan sebelumnya atau pengalaman kerja tidak selalu berkorelasi dengan tingkat pengetahuan lebih tinggi tentang perawatan paliatif, perawat yang telah menjalani pelatihan khusus dalam layanan hospice dan perawatan paliatif lebih cenderung menerapkan perawatan paliatif kepada pasien mereka dibandingkan dengan perawat yang tidak memiliki pelatihan tersebut.

Selain kurangnya pendidikan dalam perawatan paliatif, sebagian dari keraguan perawat untuk terlibat dalam perawatan paliatif dapat terkait dengan hubungan yang mereka bangun dengan pasien. Perawat mungkin tidak menyadari ketika pasien mereka mendekati akhir hayat. Mereka mungkin lebih memilih untuk mempertahankan harapan akan kesembuhan daripada membantu pasien dan pengasuh mendefinisikan ulang harapan dalam konteks penyakit yang membatasi kehidupan. Menghindari percakapan yang secara emosional intens mungkin tampak membantu pasien dan pengasuh dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan dilema etis dan moral jika perawatan paliatif dan topik akhir hayat belum pernah dibahas sebelumnya ketika keputusan mendesak harus diambil.

G. Tantangan Pelaksanaan Peran Perawat Paliatif

Umumnya literatur atau penelitian menyajikan berbagai tantangan dan hambatan pelaksanaan perawatan paliatif secara umum, tidak hanya spesifik

pelaksanaan peran perawat saja. Tantangan dan hambatan pelaksanaan perawatan paliatif tentu saja juga akan mempengaruhi pelaksanaan peran perawat paliatif. Berdasarkan review yang dilakukan oleh Effendy et al. (2022), tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perawatan paliatif, khususnya di ICU adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kapabilitas

Hambatan terbesar adalah keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelatihan dalam perawatan paliatif. Selain itu, sebuah studi oleh Ozga et al. menyoroti kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit dalam menyediakan pelatihan untuk perawatan di akhir hayat (EOL). Hal ini menghambat perawat dalam memahami perawatan paliatif dengan lebih baik, khususnya terkait EOL care. Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai perawatan EOL menjadi tantangan dalam mengintegrasikan perawatan paliatif, menangani persoalan seputar kematian, dan meningkatkan komunikasi. Studi oleh McKeown et al. menyatakan bahwa pendidikan dapat membekali tim ICU dalam menghadapi permasalahan terkait perawatan paliatif serta EOL care. Beberapa penelitian juga menemukan adanya kurangnya komunikasi antara tim medis dan keluarga pasien. Bukti dari penelitian yang ditinjau menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga terkait pengambilan keputusan medis.

2. Hambatan dari keluarga

Hambatan lain dalam penerapan perawatan paliatif di ICU adalah batasan yang muncul dari pihak keluarga, yang telah lama menjadi tantangan dalam integrasi perawatan paliatif ke dalam protokol ICU. Banyak keluarga memiliki ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menyulitkan tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip perawatan paliatif yang berfokus pada kenyamanan pasien dan dapat berujung pada pengobatan agresif. Sebuah studi oleh Kyeremanteng et al. menemukan bahwa harapan yang tidak realistis dari pasien atau keluarga menjadi hambatan dalam pemberian EOL care di ICU. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman medis dari keluarga terhadap kondisi pasien yang berada dalam tahap akhir kehidupannya. Studi lain oleh Espinosa et al. juga mengidentifikasi bahwa ekspektasi yang tidak realistis menjadi tantangan dalam penerapan perawatan paliatif, terutama dalam perawatan EOL.

3. Hambatan praktis

Masalah praktis juga menjadi hambatan besar dalam pemberian perawatan paliatif di ICU. Beberapa faktor yang menjadi kendala termasuk waktu yang terbatas untuk tugas administratif dan dokumentasi, perbedaan pendapat mengenai tujuan perawatan antar tenaga kesehatan, perbedaan pendekatan antara keperawatan dan medis, serta kebijakan administratif dalam pengobatan. Dalam praktiknya, terdapat kesepakatan dan ketidaksepakatan antara tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan paliatif di ICU. Studi oleh Festic et al. menemukan bahwa baik dokter maupun perawat sepakat bahwa kematian pasien bukanlah kegagalan pengobatan dan bahwa memberikan EOL care merupakan pengalaman yang bermakna. Namun, ketidaksepakatan juga umum terjadi antara dokter dan perawat, terutama dalam keputusan perawatan bagi pasien yang sekarat. Perawat sering merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan perawatan dan hanya menjalankan keputusan yang dibuat oleh dokter dan keluarga. Kurangnya kebijakan dan praktik yang memadai juga diidentifikasi sebagai hambatan dalam pemberian EOL care di ICU.

Perbedaan antara model medis dan keperawatan juga menjadi hambatan. Model medis lebih berfokus pada penyakit dan disfungsi, sedangkan perawat cenderung menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh aspek pasien. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesulitan bagi perawat dalam melaksanakan arahan dokter, yang dapat menyebabkan frustrasi, terutama dalam pemberian EOL care. Masalah praktis lainnya adalah kurangnya dokumentasi. Studi oleh Graw et al. menemukan bahwa kurangnya dokumentasi terkait arahan medis di masa depan menjadi hambatan signifikan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan sesuai keinginan pasien. Hambatan lain yang diidentifikasi termasuk kurangnya koordinasi, keterbatasan waktu dan tenaga kerja, serta isu etika.

4. Perbedaan budaya

Perbedaan budaya juga menjadi tantangan dalam pemberian perawatan paliatif di ICU. Dalam tinjauan ini, hanya satu penelitian yang menyoroti aspek ini. Ganz dan Sapir menyatakan bahwa dokter di Asia cenderung lebih agresif dalam pengobatan dibandingkan dengan dokter di negara Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan budaya, di mana kematian sering kali tidak dibicarakan secara terbuka di Asia, sehingga menghambat diskusi terkait keputusan EOL care.

H. Penutup

Perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius melalui manajemen gejala, dukungan emosional, dan pendekatan holistik. Berbeda dari pengobatan kuratif, perawatan ini dapat diberikan pada setiap tahap penyakit, baik bersamaan dengan pengobatan maupun sebagai pendekatan utama saat penyembuhan tidak memungkinkan.

Perawat memiliki peran penting dalam perawatan paliatif, termasuk manajemen nyeri, komunikasi efektif, dan advokasi pasien. Manajemen nyeri merupakan aspek utama, mengingat pentingnya mengatasi keluhan pasien secara fisik dan emosional. Komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dapat meningkatkan efektivitas perawatan dan mengurangi tekanan emosional.

Meskipun perawatan paliatif semakin diakui, masih terdapat hambatan dalam penerapannya, termasuk keterbatasan pendidikan tenaga kesehatan, hambatan budaya, dan kurangnya pemahaman pasien serta keluarga. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, terutama perawat, harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Perawatan paliatif dapat diterapkan di berbagai lingkungan layanan kesehatan, termasuk ICU, unit gawat darurat, dan rumah lansia, meskipun tidak semua fasilitas kesehatan di Indonesia memiliki unit khusus untuk perawatan ini. Integrasi perawatan paliatif sejak dini dalam perjalanan penyakit dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

Referensi

- Alghamdi, F. A., Alahmed, Z. A., Sowadi, S. Y., Alkhulaif, Z. A., Bubshait, S. W., Alsiyahi, L. M., Alqarni, A. H., Alhajji, F. H., Aljameeli, H. B., & Alharbi, A. S. (2023). Nursing role and strategy in pain management in palliative care. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), 398-402. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233830>
- Djelantik, A., Smid, G. E., Mroz, A., Kleber, R. J., & Boelen, P. A. (2020). The prevalence of prolonged grief disorder in bereaved individuals following unnatural losses: Systematic review and meta regression analysis. *J Affect Disord*, 265, 146-156. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.034>
- Effendy, C., Yodang, Y., Amalia, S., & Rochmawati, E. (2022). Barriers and facilitators in the provision of palliative care in adult intensive care units: a scoping review. *Acute and critical care*, 37(4), 516.
- Ellington, L., Reblin, M., Clayton, M. F., Berry, P., & Mooney, K. (2012). Hospice nurse communication with patients with cancer and their family caregivers. *J Palliat Med*, 15(3), 262-268. <https://doi.org/10.1089/jpm.2011.0287>
- Engel, M., Kars, M. C., Teunissen, S. C. C. M., & van der Heide, A. (2023). Effective communication in palliative care from the perspectives of patients and relatives: A systematic review. *Palliative and Supportive Care*, 21(5), 890-913. <https://doi.org/10.1017/S1478951523001165>
- Fitch, M. I., Fliedner, M. C., & O'Connor, M. (2015). Nursing perspectives on palliative care 2015. *ANNALS OF PALLIATIVE MEDICINE*, 4(3), 150-155. <https://apm.amegroups.org/article/view/7034>
- Hagan, T. L., Xu, J., Lopez, R. P., & Bressler, T. (2018). Nursing's role in leading palliative care: A call to action. *Nurse Educ Today*, 61, 216-219. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.11.037>
- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Huang, T.-W., Jen, H.-J., Liu, D., Shen Hsiao, S.-T., & Chou, K.-R. (2022). Prevalence of grief disorders in bereaved families of cancer patients: A meta-analysis. *PALLIATIVE MEDICINE*, 36(2), 305-318. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1177/02692163211066747>
- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Pien, L. C., Chen, R., Tsai, H. T., & Chou, K. R. (2022). Anticipatory grief prevalence among caregivers of persons with a life-threatening illness: A meta-analysis [Article in Press]. *BMJ SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE*. <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2021-003338>
- Kustanti, C. Y., Fang, H. F., Linda Kang, X., Chiou, J. F., Wu, S. C., Yunitri, N., Chu, H., & Chou, K. R. (2021). The Effectiveness of Bereavement Support for Adult Family Caregivers in Palliative Care: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.

- JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP*, 53(2), 208-217.
<https://doi.org/10.1111/jnu.12630>
- Kustanti, C. Y., Jen, H. J., Chu, H., Liu, D., Chen, R., Lin, H. C., Chang, C. Y., Pien, L. C., Chiang, K. J., & Chou, K. R. (2023). Prevalence of grief symptoms and disorders in the time of COVID-19 pandemic: A meta-analysis. *Int J Ment Health Nurs*, 32(3), 904-916. <https://doi.org/10.1111/inm.13136>
- Lundorff, M., Holmgren, H., Zachariae, R., Farver-Vestergaard, I., & O'Connor, M. (2017). Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*, 212, 138-149. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.01.030>
- Martina, D., Kustanti, C. Y., Dewantari, R., Sutandyo, N., Putranto, R., Shatri, H., Effendy, C., van der Heide, A., van der Rijt, C. C. D., & Rietjens, J. A. C. (2022). Advance care planning for patients with cancer and family caregivers in Indonesia: a qualitative study. *BMC Palliat Care*, 21(1), 204. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-01086-0>
- Murtagh, F. E., Bausewein, C., Verne, J., Groeneveld, E. I., Kaloki, Y. E., & Higginson, I. J. (2014). How many people need palliative care? A study developing and comparing methods for population-based estimates. *PALLIATIVE MEDICINE*, 28(1), 49-58.
- Paice, J. A., Battista, V., Drick, C. A., & Schreiner, E. (2018). Palliative Nursing Summit: Nurses Leading Change and Transforming Primary Palliative Care: Nursing's Role in Providing Pain and Symptom Management. *JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING*, 20(1). https://journals.lww.com/jhpn/fulltext/2018/02000/palliative_nursing_summit_nurses_leading_change.6.aspx
- St Marie, B. (2013). Pain management in patients receiving palliative care. *Oncol Nurse Advis*, 2013, e1-e6.
- Thacker, K. S. (2008). Nurses' advocacy behaviors in end-of-life nursing care. *Nurs Ethics*, 15(2), 174-185. <https://doi.org/10.1177/0969733007086015>
- WHO. (2020). *Palliative care*. Retrieved July 20, 2023 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>

Glosarium

A

Advokasi pasien: Peran perawat dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan pasien untuk memastikan mereka menerima perawatan yang sesuai.

Aspek psikososial: Faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraan pasien.

Aspek spiritual: Elemen kepercayaan dan makna hidup yang dapat mempengaruhi penerimaan pasien terhadap kondisi kesehatannya.

B

Beban emosional: Tekanan psikologis yang dialami pasien dan keluarga selama proses perawatan penyakit serius.

C

Caregiver (pengasuh): Individu yang merawat pasien, baik dari keluarga maupun tenaga kesehatan profesional.

D

Dukungan emosional: Bantuan yang diberikan kepada pasien dan keluarga untuk mengatasi stres, kecemasan, dan beban psikologis akibat penyakit yang dihadapi.

H

Hospis: Layanan perawatan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit terminal untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup mereka.

I

Integrasi perawatan paliatif: Proses menggabungkan perawatan paliatif ke dalam sistem layanan kesehatan umum untuk memastikan akses yang lebih luas.

K

Keputusan pengobatan: Proses penentuan pilihan terapi berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan kondisi pasien.

Kesejahteraan holistik: Pendekatan dalam perawatan yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu.

Keterampilan interpersonal: Kemampuan perawat dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga secara empatik, mendukung, dan profesional.

Komunikasi efektif: Kemampuan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara jelas, empatik, dan terbuka kepada pasien serta keluarga.

Kualitas hidup: Tingkat kesejahteraan pasien dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

M

Manajemen gejala: Proses mengidentifikasi, menilai, dan mengobati gejala yang muncul akibat penyakit serius untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

Manajemen nyeri: Upaya medis dan non-medis untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri yang dialami pasien dalam perawatan paliatif.

N

Nyeri neuropatik: Nyeri yang terjadi akibat kerusakan atau disfungsi sistem saraf, sering kali ditandai dengan sensasi terbakar atau kesemutan.

Nyeri nosiseptif: Jenis nyeri yang disebabkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, sering kali bersifat tajam atau berdenyut.

P

Pedoman etika keperawatan: Prinsip moral dan profesional yang membimbing praktik keperawatan dalam memberikan pelayanan yang adil dan berorientasi pada pasien.

Pengobatan kuratif: Pendekatan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, berbeda dengan perawatan paliatif yang berfokus pada manajemen gejala dan kenyamanan pasien.

Perawatan jangka panjang: Layanan yang diberikan kepada individu dengan kondisi kesehatan kronis atau terminal yang memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari.

Perawatan paliatif: Pendekatan dalam layanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dengan penyakit serius dan mengancam jiwa

melalui manajemen gejala, dukungan emosional, dan kesejahteraan holistik (WHO, 2020).

T

Tim interdisipliner: Kelompok tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama dalam memberikan perawatan holistik kepada pasien.

U

Unit Gawat Darurat (UGD): Departemen di rumah sakit yang menangani pasien dalam kondisi darurat medis.

Unit Perawatan Intensif (ICU): Bagian dari rumah sakit yang menyediakan perawatan medis tingkat tinggi bagi pasien dengan kondisi kritis.

V

Vulnerabilitas pasien: Keadaan di mana pasien berada dalam kondisi rentan akibat penyakit serius, memerlukan perhatian khusus dalam perawatan.

BAB II

PENDEKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PASIEN PALIATIF

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang mengutamakan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius dan tak dapat disembuhkan. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan perawatan itu sendiri. Sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan tenaga medis, komunikasi bukan hanya sekadar sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun rasa aman, empati, dan kepercayaan yang mendalam.

Komunikasi yang berbasis pada empati, kejelasan, dan keterbukaan memiliki peran sentral dalam membantu pasien mengatasi ketakutan, kecemasan, serta kesepian yang sering muncul pada fase akhir kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang penuh perhatian dan kesadaran, komunikasi mampu memberikan ruang bagi pasien untuk berbagi perasaan, harapan, dan kebutuhan mereka secara bebas, sehingga mereka tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga terlibat dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan perawatan mereka.

Lebih dari itu, komunikasi yang efektif juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memahami dan mendukung perjalanan pasien, serta berperan dalam pengambilan keputusan yang sensitif dan penuh pertimbangan. Dalam dunia perawatan paliatif, komunikasi yang terbuka dan penuh empati bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memberikan ketenangan dan pengharapan, bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap pasien, meskipun berada dalam kondisi yang tidak mudah, tetap merasa dihargai, diberdayakan, dan didukung.

Dengan pendekatan yang lebih formal dan profesional, pendahuluan ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai pentingnya komunikasi dalam perawatan paliatif, sambil tetap menarik perhatian pembaca pada topik yang akan dibahas lebih lanjut.

B. Prinsip Komunikasi Paliatif

Perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit terminal atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan menekankan pada pengelolaan gejala dan dukungan emosional. Salah satu elemen yang sangat penting dalam perawatan paliatif adalah komunikasi yang

efektif. Komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman antara pasien, keluarga, dan tenaga medis, tetapi juga memberikan rasa tenang, mengurangi kecemasan, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam perawatan paliatif, komunikasi yang berbasis pada empati, kejelasan, dan keterbukaan menjadi kunci utama untuk menciptakan hubungan yang sehat antara semua pihak yang terlibat.

1. Komunikasi Berbasis Empati

Empati merupakan inti dari komunikasi dalam perawatan paliatif. Ketika tenaga medis dapat merasakan dan memahami perasaan pasien, ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang lebih mendalam tetapi juga memfasilitasi penyampaian perawatan yang lebih holistik. Menurut *Ong, Tan, dan Lee* (2019), empati memungkinkan tenaga medis untuk menghubungkan perasaan mereka dengan perasaan pasien, yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan emosional pasien selama perawatan paliatif.

Empati tidak hanya berarti mendengarkan kata-kata pasien, tetapi juga merasakan ketakutan, kesedihan, dan kecemasan mereka. Sebagai contoh, ketika seorang pasien yang menghadapi kanker stadium lanjut mengungkapkan ketakutannya terhadap rasa sakit, tenaga medis yang empatik akan memberikan respons yang menenangkan, menawarkan dukungan, dan memastikan bahwa pasien merasa dihargai dalam proses perawatan mereka.

Komunikasi empatik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan membantu mereka merasa didengar dan diperhatikan, meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, empati berperan sebagai alat penting dalam mendukung kesehatan emosional pasien dan membangun hubungan yang saling percaya.

a. Contoh Komunikasi Berbasis Empati oleh Perawat

Situasi:

Seorang pasien berusia 70 tahun yang didiagnosis dengan kanker pankreas stadium lanjut sedang menjalani perawatan paliatif. Pasien merasa cemas dan takut tentang rasa sakit yang mungkin timbul seiring perkembangan penyakitnya. Ia juga merasa khawatir tentang kualitas hidup yang akan menurun. Pasien mengungkapkan ketakutannya kepada perawat saat perawatan rutin.

b. Langkah-langkah Komunikasi Empati oleh Perawat:

1) Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Perawat memberikan perhatian penuh pada pasien, menciptakan ruang untuk pasien berbicara tentang perasaannya tanpa terburu-buru memberikan solusi. Perawat memastikan bahwa pasien merasa didengarkan dan dihargai.

Perawat:

"Saya mendengar kekhawatiran Anda tentang rasa sakit yang mungkin muncul. Ini adalah perasaan yang sangat normal, dan saya di sini untuk mendengarkan dan membantu Anda. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang apa yang membuat Anda merasa takut atau cemas?"

2) Menunjukkan Empati dan Menghargai Perasaan Pasien

Setelah mendengarkan pasien, perawat mengakui dan memvalidasi perasaan pasien tanpa meremehkan atau mengabaikan ketakutannya.

Perawat:

"Saya bisa memahami betapa beratnya situasi ini bagi Anda. Tidak mudah menjalani perawatan dengan rasa takut akan rasa sakit yang datang. Itu bisa sangat menegangkan, dan Anda berhak merasa khawatir. Kami akan bekerja sama untuk memastikan Anda merasa lebih nyaman."

3) Memberikan Dukungan Emosional dan Penjelasan Tentang Pengelolaan Rasa Sakit

Perawat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola rasa sakit pasien. Penjelasan dilakukan dengan cara yang menenangkan dan penuh pengertian.

Perawat:

"Ada beberapa cara untuk mengelola rasa sakit, dan kami akan memantau kondisi Anda dengan cermat. Kami bisa menggunakan obat-obatan atau terapi lain untuk memastikan rasa sakit Anda terkendali. Jangan khawatir, Anda tidak akan menghadapinya sendirian—kami akan membantu Anda setiap langkahnya."

4) Mendorong Keterbukaan dan Komunikasi Lanjutan

Perawat memastikan bahwa pasien merasa aman untuk berbicara lebih lanjut jika ada kekhawatiran lainnya di masa depan. Ini memberikan rasa kontrol dan kenyamanan bagi pasien.

Perawat:

"Jika Anda merasa ada hal lain yang ingin dibicarakan atau jika Anda merasa cemas tentang apa pun, saya di sini untuk Anda. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan Anda kapan saja."

Hasil dari Komunikasi Empatik:

Pasien merasa lebih tenang dan dihargai setelah berbicara dengan perawat. Ketakutannya terhadap rasa sakit tidak hanya diakui tetapi juga dipahami

secara emosional oleh perawat. Pasien merasa lebih diberdayakan dan lebih siap menghadapi perawatan mereka, karena merasa memiliki dukungan emosional yang kuat

2. Komunikasi yang Jelas dan Terbuka

Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting dalam perawatan paliatif. Dalam banyak kasus, pasien dan keluarga mereka sering merasa bingung atau cemas tentang prognosis penyakit, pilihan pengobatan, dan potensi hasil perawatan. Menurut *Doyle, Hanks, dan MacDonald* (2015), komunikasi yang transparan memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang lebih baik dan penuh pertimbangan mengenai perawatan mereka. Ketika informasi disampaikan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami, pasien dan keluarga merasa lebih berdaya dan lebih mampu menghadapinya.

Sebagai contoh, seorang pasien yang baru didiagnosis dengan penyakit terminal akan merasa lebih tenang jika tenaga medis dapat menjelaskan dengan jelas tentang kondisi mereka, termasuk harapan hidup yang realistis, serta pilihan-pilihan perawatan yang tersedia. Komunikasi yang transparan juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan perasaan dan keinginan mereka terkait pengelolaan perawatan yang akan mereka terima.

a. Contoh Komunikasi yang Jelas dan Terbuka oleh Perawat

Situasi:

Seorang pasien berusia 60 tahun yang menderita kanker paru-paru stadium lanjut sedang menjalani perawatan paliatif. Pasien merasa bingung dan cemas tentang pengobatan yang sedang dijalannya, terutama terkait dengan efek samping obat penghilang rasa sakit dan pengaruhnya terhadap kualitas hidupnya. Pasien mengungkapkan kebingungannya kepada perawat saat perawatan rutin.

b. Langkah-langkah Komunikasi Jelas dan Terbuka oleh Perawat:

- 1) Memberikan Penjelasan yang Jelas tentang Kondisi Pasien dan Pengobatan
Perawat pertama-tama memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasien dan tujuan pengobatan yang sedang dijalani. Ini membantu pasien untuk memahami dengan lebih baik mengapa perawatan tersebut diperlukan dan apa yang diharapkan.

Perawat:

"Kami telah mendeteksi bahwa kanker Anda sudah mencapai tahap yang cukup lanjut, dan tujuan utama dari perawatan paliatif adalah untuk memastikan Anda merasa nyaman dan mengurangi rasa sakit. Kami akan berfokus pada pengelolaan gejala dan meningkatkan kualitas hidup Anda."

2) Mengungkapkan Pilihan Perawatan dengan Jelas dan Terbuka

Perawat memberikan informasi tentang berbagai pilihan pengelolaan rasa sakit dan perawatan yang dapat dipilih oleh pasien, serta efek samping yang mungkin timbul, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang informasional.

Perawat:

"Untuk mengelola rasa sakit Anda, ada beberapa pilihan pengobatan. Kami bisa menggunakan obat pereda nyeri yang lebih ringan atau mungkin memerlukan terapi penghilang rasa sakit yang lebih kuat jika diperlukan. Setiap pilihan ini memiliki efek samping tertentu, seperti kantuk atau mual, yang biasanya akan berkurang seiring waktu, tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui ini agar dapat membuat pilihan yang sesuai."

3) Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Dapat Dimengerti

Perawat memastikan bahwa penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menggunakan istilah medis yang rumit, sehingga pasien merasa lebih nyaman dan lebih mengerti tentang proses perawatan mereka.

Perawat:

"Obat yang kita gunakan bisa membuat Anda merasa sedikit mengantuk, tetapi ini akan membantu mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Jika ada efek samping lain yang Anda rasakan, atau jika Anda merasa tidak nyaman, beri tahu kami segera. Kami akan menyesuaikan dosis atau obat yang digunakan."

4) Memberikan Ruang untuk Pertanyaan dan Klarifikasi

Perawat kemudian membuka ruang bagi pasien untuk bertanya atau meminta klarifikasi jika ada hal yang belum dimengerti. Ini penting untuk memastikan bahwa pasien merasa diberdayakan dan memiliki pemahaman yang jelas.

Perawat:

"Apakah ada hal lain yang Anda ingin ketahui lebih lanjut atau ada bagian dari penjelasan saya yang belum jelas? Kami di sini untuk membantu Anda, dan saya ingin pastikan Anda merasa nyaman dengan informasi yang kami berikan."

5) Menyampaikan Komitmen untuk Terus Menyediakan Dukungan

Setelah memberikan penjelasan, perawat mengingatkan pasien bahwa mereka dapat menghubungi tim perawatan kapan saja jika ada pertanyaan lebih lanjut atau masalah yang muncul.

Perawat:

"Jika Anda merasa cemas atau ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami kapan saja. Kami akan terus bekerja bersama Anda untuk memastikan Anda merasa sebaik mungkin selama perawatan."

c. Hasil dari Komunikasi yang Jelas dan Terbuka:

Pasien merasa lebih tenang dan diberdayakan setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan tentang pengobatan yang diterimanya. Dengan memahami pilihan yang ada dan efek samping yang mungkin timbul, pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai perawatan mereka, dan perasaan cemas mereka berkurang. Komunikasi terbuka juga membantu membangun rasa percaya antara pasien dan perawat.

3. Mendengarkan secara Aktif

Selain berbicara dengan jelas, mendengarkan secara aktif adalah keterampilan komunikasi yang esensial dalam perawatan paliatif. *Epstein dan Street* (2011) menyatakan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian memungkinkan tenaga medis untuk lebih memahami pengalaman pasien, yang sangat penting dalam perawatan yang berfokus pada pasien. Dengan mendengarkan secara aktif, tenaga medis dapat lebih baik merespons kebutuhan emosional dan fisik pasien, yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung tetapi dapat ditangkap melalui isyarat verbal dan non-verbal.

Mendengarkan dengan aktif menciptakan ruang bagi pasien untuk berbagi kecemasan, keinginan, dan harapan mereka, yang memungkinkan tenaga medis untuk merespons secara lebih pribadi dan penuh empati. Ini juga mengurangi ketidakpastian yang sering dialami oleh pasien dalam perawatan paliatif dan memperkuat hubungan antara pasien dan tenaga medis.

Contoh:

seorang pasien merasa cemas tentang kemungkinan efek samping dari pengobatan paliatif yang diresepkan, tenaga medis dapat mendengarkan dengan cermat kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang jelas, menawarkan solusi, serta memberi ruang bagi pasien untuk berbicara lebih lanjut tentang kekhawatiran mereka.

4. Komunikasi yang Menghormati Autonomi Pasien

Dalam perawatan paliatif, sangat penting untuk menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Komunikasi yang menghormati otonomi pasien adalah prinsip dasar yang melibatkan penghargaan terhadap pilihan dan keputusan pasien, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Menurut *Beresford* (2017), tenaga medis harus

memberikan pasien kesempatan untuk mengungkapkan keinginan mereka dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang baik tentang pilihan-pilihan yang ada.

Contoh:

Sebagai contoh, jika pasien ingin memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan yang agresif dan memilih perawatan yang lebih nyaman, tenaga medis harus menghormati pilihan tersebut dan memberikan dukungan penuh dalam keputusan tersebut, sambil memberikan informasi yang relevan untuk membantu pasien membuat keputusan yang lebih informasional.

C. Strategi Komunikasi Efektif dengan Pasien Paliatif

Komunikasi yang efektif dengan pasien paliatif memerlukan pendekatan yang penuh perhatian, penuh empati, dan berbasis pada kebutuhan pasien. Beberapa strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas interaksi dengan pasien paliatif antara lain pendekatan interaktif dan partisipatif serta penggunaan teknik komunikasi non-verbal. Kedua strategi ini tidak hanya penting untuk mendukung kesejahteraan fisik pasien, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam perawatan paliatif.

1. Pendekatan Interaktif dan Partisipatif

Pendekatan interaktif dan partisipatif dalam komunikasi paliatif bertujuan untuk melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Ketika pasien diberi kesempatan untuk berbicara dan memilih langkah-langkah perawatan, ini dapat membantu mereka merasa lebih dihargai dan memiliki kontrol terhadap situasi yang mereka hadapi, yang sangat penting untuk mengurangi perasaan ketidakberdayaan. Menurut *Foster et al.* (2018), pendekatan interaktif yang memungkinkan pasien berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan perawatan dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima.

Contoh Penerapan pada Pasien Paliatif:

Seorang pasien pria berusia 70 tahun yang menderita kanker paru-paru stadium akhir sedang menjalani perawatan paliatif di rumah sakit. Dia merasa cemas tentang rasa sakit yang semakin parah, dan ada kekhawatiran mengenai kualitas hidup yang menurun. Ketika perawat datang untuk memberikan update perawatan, perawat menggunakan pendekatan interaktif untuk melibatkan pasien dalam keputusan terkait pengelolaan rasa sakit.

Perawat:

"Pak, saya ingin memastikan Anda merasa nyaman dengan perawatan yang kita berikan. Kami memiliki beberapa opsi untuk mengelola rasa sakit, dan saya ingin mendengar pendapat Anda tentang pilihan-pilihan tersebut. Apakah Anda lebih memilih untuk menggunakan obat penghilang rasa sakit yang lebih ringan atau ada opsi lain yang ingin Anda pertimbangkan?"

Pasien:

"Saya khawatir obat penghilang rasa sakit yang kuat akan membuat saya merasa terlalu mengantuk atau tidak sadar. Saya ingin tetap dapat berinteraksi dengan keluarga."

Perawat:

"Saya mengerti kekhawatiran Anda. Mari kita diskusikan opsi yang memungkinkan Anda merasa nyaman tetapi juga menjaga tingkat kewaspadaan Anda. Kami juga bisa menyesuaikan dosis sesuai dengan kebutuhan Anda, jadi Anda tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga."

Pendekatan ini memberi pasien kontrol lebih besar atas perawatan yang mereka terima, sehingga mengurangi rasa cemas mereka dan memberi mereka rasa dihargai dalam pengambilan keputusan.

2. Menggunakan Teknik Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi non-verbal, seperti kontak mata, senyum, dan sentuhan lembut, memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan emosional yang lebih dalam antara tenaga medis dan pasien, terutama dalam perawatan paliatif. Menurut *McMillan et al.* (2016), komunikasi non-verbal yang terbuka dan penuh perhatian dapat memberikan kenyamanan emosional yang signifikan, memperkuat pesan verbal, dan membantu pasien merasa lebih aman, dihargai, dan nyaman.

Contoh Penerapan pada Pasien Paliatif:

Seorang pasien perempuan berusia 60 tahun dengan kanker payudara stadium lanjut yang menerima perawatan paliatif di rumah sakit merasa sangat cemas dan kesepian. Dia sering merasa terisolasi di kamar rumah sakit dan tidak ingin berbicara tentang rasa sakitnya. Pada suatu pagi, seorang perawat mendekat untuk memberikan obat dan memulai percakapan dengan menggunakan teknik komunikasi non-verbal yang lembut.

Perawat:

(Menggunakan kontak mata lembut dan senyum) "Selamat pagi, Ibu. Saya tahu Anda merasa tidak enak badan. Bagaimana keadaan Anda hari ini?" (Perawat juga mengusap lembut tangan pasien saat berbicara.)

Pasien:

"Saya merasa sedikit lelah, tapi saya tidak ingin memberatkan Anda dengan keluhan saya."

Perawat:

"Tidak perlu khawatir, Ibu. Kami ada di sini untuk memastikan Anda merasa sebaik mungkin. Jika ada yang bisa kami bantu, baik itu untuk rasa sakit atau perasaan Anda, kami akan ada untuk membantu Anda."

Dalam contoh ini, perawat menggunakan sentuhan lembut di tangan pasien dan kontak mata untuk menunjukkan perhatian dan empati. Senyum lembut dan respons yang penuh perhatian membantu mengurangi kecemasan pasien dan membuatnya merasa dihargai dan dipahami, meskipun dalam kondisi fisik yang sangat sulit.

D. Tantangan dalam Komunikasi dengan Pasien Paliatif

Komunikasi yang efektif dengan pasien paliatif adalah kunci dalam memastikan kualitas perawatan yang tinggi dan pengalaman yang lebih baik bagi pasien dan keluarga mereka. Namun, beberapa tantangan sering kali muncul, terutama dalam hal ketakutan dan kecemasan pasien serta komunikasi dengan keluarga pasien. Setiap tantangan membutuhkan pendekatan yang penuh perhatian, berbasis pada empati, dan penuh pengertian.

1. Ketakutan dan Kecemasan Pasien

Tantangan:

Pasien paliatif sering kali mengalami ketakutan dan kecemasan yang mendalam terkait dengan prognosis yang buruk, rasa sakit, dan kemungkinan kematian yang semakin dekat. Ketakutan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai kondisi mereka atau kesulitan mereka dalam menerima kenyataan tentang penyakit yang mereka derita. Menurut Smith et al. (2020), kecemasan pasien sering kali berakar dari ketidakpastian mengenai pengobatan dan masa depan mereka, serta ketakutan tentang rasa sakit yang akan datang.

Contoh Penerapan oleh Perawat:

Seorang pasien pria berusia 75 tahun yang menderita kanker pankreas stadium akhir sedang menjalani perawatan paliatif. Pasien tersebut merasa sangat cemas tentang rasa sakit yang semakin memburuk dan khawatir tentang bagaimana kondisinya akan berkembang. Saat perawat datang untuk memeriksa pasien, ia menyampaikan kekhawatirannya tentang rasa sakit yang akan datang.

Pasien:

"Saya sangat takut akan rasa sakit yang datang nanti. Apa yang akan terjadi jika saya tidak bisa menghadapinya? Saya merasa seperti saya kehilangan kontrol atas tubuh saya."

Perawat (Mendengarkan dengan empati):

"Saya bisa memahami ketakutan Anda, Pak. Rasa sakit memang bisa sangat menakutkan, terutama saat kita tahu bahwa penyakit ini semakin parah. Tapi, saya ingin memastikan Anda tahu bahwa kami di sini untuk membantu Anda mengelola rasa sakit dengan cara yang paling nyaman. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memastikan rasa sakit tidak mengganggu Anda. Kami akan bekerja sama untuk menemukan yang terbaik."

Perawat (Memberikan informasi yang jelas dan tenang):

"Kami akan terus memantau tingkat rasa sakit Anda dan menyesuaikan obat atau terapi penghilang rasa sakit agar Anda merasa nyaman. Jika ada efek samping atau kekhawatiran, kami akan segera menanganinya. Anda tidak sendirian dalam hal ini."

Dalam contoh ini, perawat tidak hanya memberikan penjelasan yang menenangkan tetapi juga mengurangi kecemasan pasien dengan memastikan mereka bahwa perawatan untuk mengelola rasa sakit akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

2. Komunikasi dengan Keluarga Pasien

Tantangan:

Keluarga pasien memainkan peran yang sangat penting dalam perawatan paliatif. Mereka tidak hanya menjadi pendukung utama bagi pasien secara emosional, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan pasien. Hearn dan Higginson (2017) menyatakan bahwa mengelola ekspektasi keluarga dan memastikan bahwa keputusan medis yang diambil mencerminkan keinginan pasien merupakan tantangan besar dalam perawatan paliatif. Keluarga sering kali

merasa cemas tentang kondisi pasien dan bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi pasien.

Contoh Penerapan oleh Perawat:

Seorang pasien perempuan berusia 68 tahun yang menderita kanker payudara stadium lanjut sedang menjalani perawatan paliatif. Keluarganya terlihat sangat cemas dan bingung mengenai apakah mereka harus melanjutkan pengobatan agresif atau beralih ke perawatan yang lebih fokus pada kenyamanan pasien. Perawat datang untuk menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan memberikan informasi yang lebih jelas.

Perawat:

"Saya mengerti bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat bagi keluarga. Saya di sini untuk memberikan informasi yang jelas tentang pilihan perawatan yang tersedia untuk ibu Anda."

Anak pasien:

"Kami merasa sangat bingung, apakah kami harus terus melanjutkan pengobatan atau beralih ke perawatan yang lebih mengutamakan kenyamanan ibu?"

Perawat (Memberikan penjelasan yang jelas):

"Perawatan agresif masih dapat membantu dalam beberapa kasus, tetapi pada tahap ini, perawatan yang lebih fokus pada kenyamanan, seperti pengelolaan rasa sakit dan perawatan paliatif, bisa membantu ibu Anda merasa lebih baik. Kami akan selalu mendiskusikan setiap pilihan dengan Anda, dan keputusan yang diambil akan mencerminkan keinginan ibu Anda."

Perawat (Menyediakan ruang untuk diskusi lebih lanjut):

"Saya ingin memastikan bahwa Anda merasa diberdayakan dalam proses ini, dan jika ada pertanyaan atau kekhawatiran lebih lanjut, saya akan siap membantu Anda kapan saja."

Dalam situasi ini, perawat memberikan ruang bagi keluarga untuk bertanya dan memastikan bahwa mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kualitas hidup pasien.

E. Penutup

Komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam perawatan paliatif, yang sangat memengaruhi kualitas hidup pasien dan mendukung kesejahteraan emosional mereka. Tantangan seperti kecemasan pasien dan komunikasi dengan keluarga membutuhkan pendekatan yang empatik, transparan, dan partisipatif. Dengan memberikan informasi yang jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepuasan pasien serta keluarga. Sebagai tenaga medis, penting untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi ini untuk memastikan pasien merasa dihargai, diberdayakan, dan nyaman selama perawatan. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu pasien menghadapi tantangan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan paliatif mereka.

Referensi

- Beresford, L. (2017). The role of patient autonomy in palliative care. *Journal of Palliative Medicine*, 29(3), 141-147.
- Doyle, D., Hanks, G., & MacDonald, N. (2015). *Oxford Textbook of Palliative Medicine* (5th ed.). Oxford University Press.
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100-103.
- Hearn, J., & Higginson, I. J. (2017). The communication challenges in palliative care: Working with families. *Palliative Medicine*, 31(5), 377-383.
- McMillan, M., Wilson, R., & Lewis, A. (2016). The role of non-verbal communication in palliative care. *Journal of Clinical Palliative Care*, 11(4), 123-129.
- Ong, C., Tan, L., & Lee, K. (2019). The role of empathy in communication with palliative patients. *Journal of Palliative Care*, 35(2), 112-118.
- Smith, K., Brown, J., & White, L. (2020). Challenges in palliative care communication: Addressing patient anxiety. *Palliative Medicine*, 34(3), 356-363.

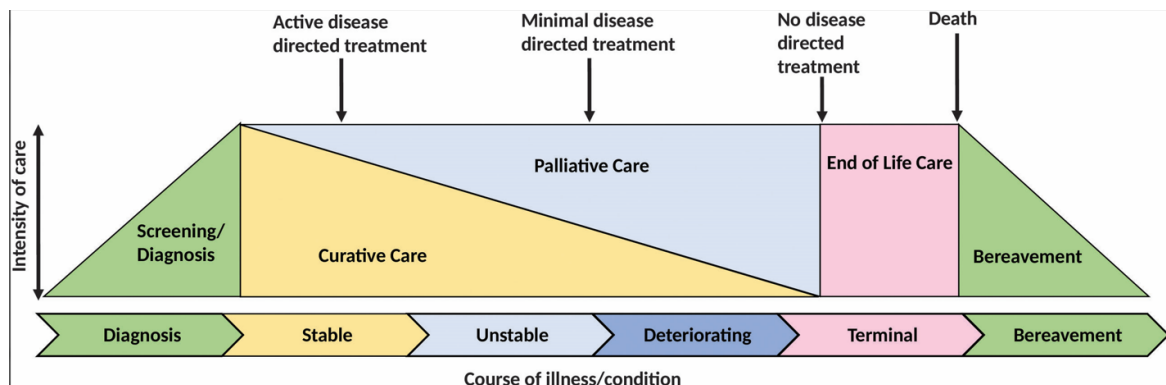
BAB III

DUKUNGAN PSIKOLOGIS BAGI KELUARGA PASIEN PALIATIF

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien (baik dewasa dan anak-anak) dan keluarga mereka yang sedang menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui tindakan pencegahan, mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, memberikan pengobatan rasa sakit dan mengatasi masalah lainnya, baik fisik, psikososial, maupun spiritual (WHO, 2018; Connor et al., 2020). Adapun tujuan perawatannya adalah meningkatkan kualitas hidup, mempromosikan martabat dan kenyamanan, dan dapat menjalani proses penyakit secara positif. Perawatan ini juga memberikan pendampingan bagi pasien dan keluarga sepanjang perjalanan penyakit (WHO, 2018). Tujuan perawatan untuk pasien dan keluarga dapat berubah dan beradaptasi tergantung pada posisi pasien dalam rangkaian fase perawatan paliatif (diagnosis, stabil, tidak stabil, memburuk, terminal, dan berkabung) seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1: Fase-fase perawatan paliatif selama perjalanan penyakit



Sumber gambar: Radford, C., Marshall, J., Herbert, A., Irving, H., & Weir, K. (2020). Risk Feeding: An Australian Pediatric Palliative Care Perspective. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, 5(2), 515–521. https://doi.org/10.1044/2020_persp-19-00032

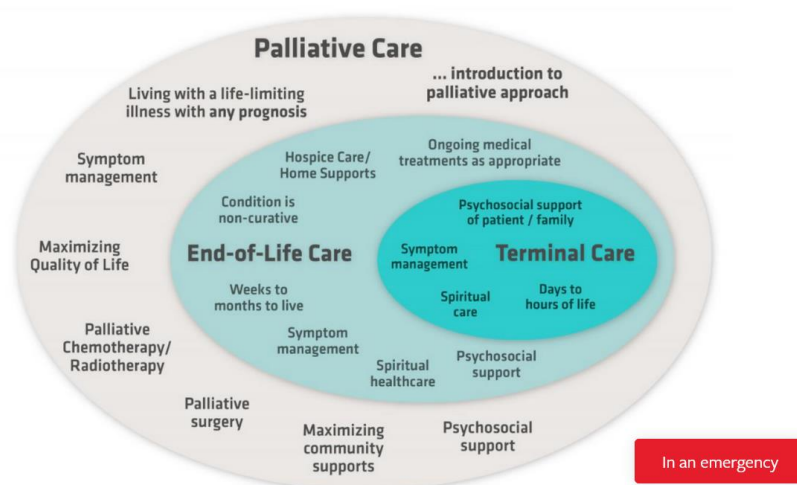
Connor et al., (2020) menerangkan beberapa kegiatan yang dilakukan di perawatan paliatif berupa:

1. Memberikan bantuan dari rasa sakit dan gejala-gejala yang tidak menyenangkan;
2. Memberikan penegasan tentang kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal;

3. Tidak bermaksud untuk mempercepat atau menunda kematian;
4. Mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual dalam perawatan pasien;
5. Menawarkan sistem pendukung untuk membantu pasien hidup seaktif mungkin hingga ajal menjemputnya;
6. Menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi masa-masa yang sulit dan berkabung;
7. Menggunakan pendekatan tim untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya, termasuk konseling saat berduka (jika diindikasikan);
8. Membantu meningkatkan kualitas hidup, dan juga dapat memengaruhi perjalanan penyakit secara positif
9. Tindakan dapat diterapkan sejak dini dalam perjalanan penyakit, bersamaan dengan terapi lain untuk memperpanjang usia (seperti kemoterapi, radiasi), dan mencakup pemeriksaan yang diperlukan dan menghadapi komplikasi klinis dengan lebih baik.

Gambar 1 mengilustrasikan struktur komprehensif dan *multilayered* dari perawatan paliatif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan penyakit serius atau kronis pada berbagai tahap penyakit mereka.

Gambar 2: *Multilayered* dari perawatan paliatif



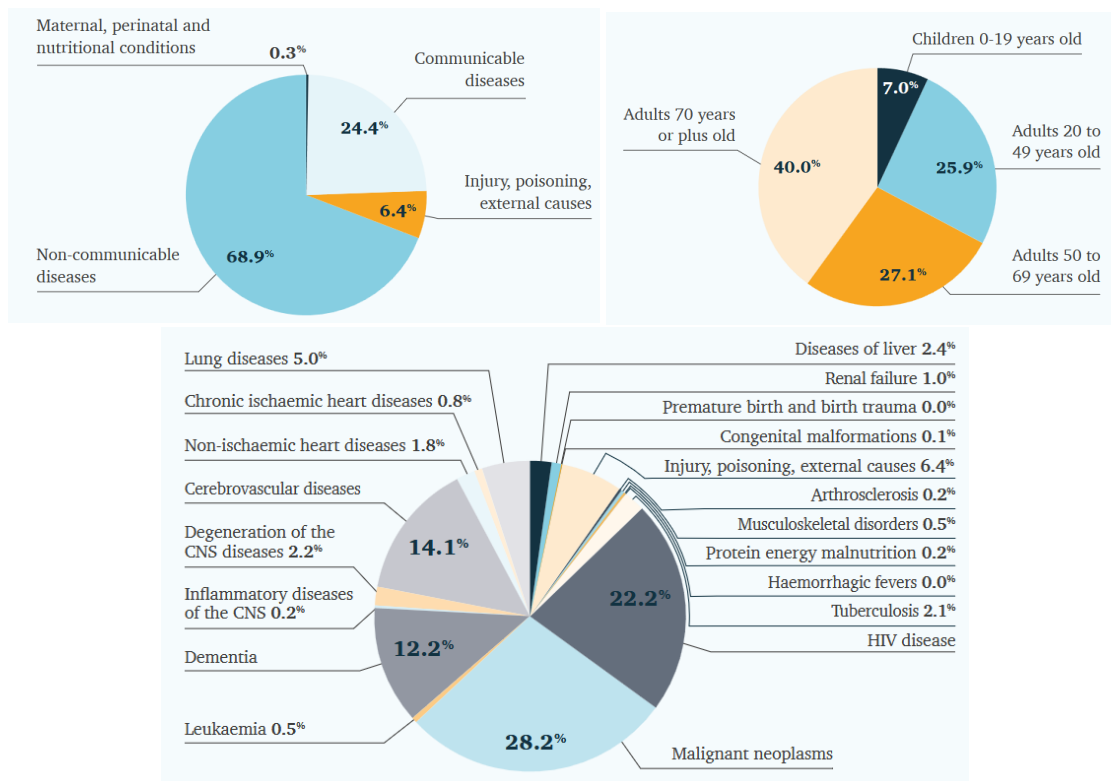
Sumber gambar: <https://www.providencehealthcare.org/en/health-services/services/health-support-services/hospice-palliative-care>

Perawatan paliatif juga semakin diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar sehingga penting untuk memastikan martabat dan kualitas hidup individu yang menghadapi penyakit serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan bahwa akses terhadap perawatan paliatif merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan, dan mengadvokasi agar perawatan paliatif dimasukkan ke dalam kebijakan dan kerangka kerja kesehatan nasional (Clelland et al., 2020; Willemsen et al., 2021).

B. Kebutuhan terhadap perawatan paliatif

WHO menyebutkan bahwa setiap tahunnya diperkirakan 56,8 juta orang di seluruh dunia membutuhkan perawatan paliatif, namun sayangnya hanya sekitar 14% dari mereka yang mendapatkannya (World Health Organization, 2020). Connor et al., (2020) menyebutkan bahwa kebutuhan dunia terhadap perawatan paliatif (gambar 2) lebih banyak pada penyakit tidak menular (68.9%), usia pasien lebih dari 70 tahun (40%) dan yang disebabkan oleh malignant neoplasma (28.2%). Akses terhadap perawatan paliatif ini masih terbatas, terutama di negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah meskipun layanan perawatan paliatif telah meningkat di 47% negara di wilayah tersebut sejak 2007 (World Health Organization, 2023).

Gambar 3: Kebutuhan perawatan paliatif di dunia



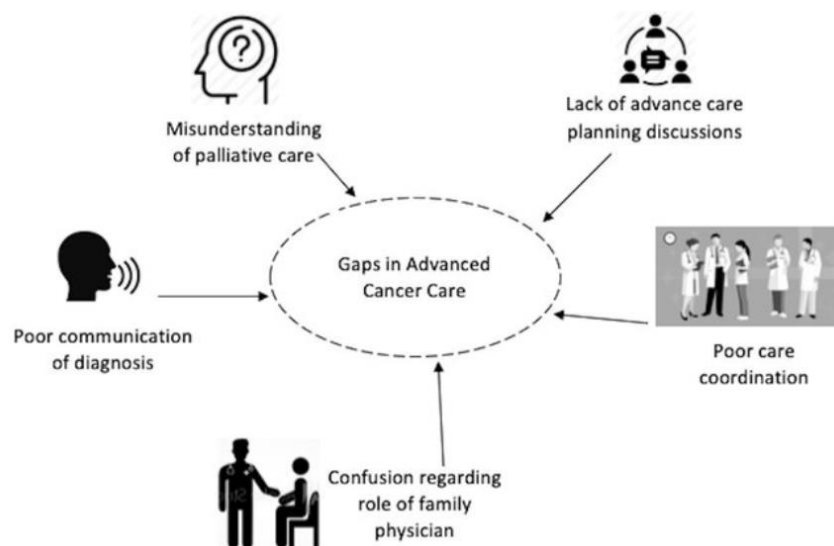
Sumber gambar: Connor, S., Morris, C., Jaramilo, E., Harding, R., Cleary, J., Haste, B., Knaul, F., Lima, L., Krakauer, E., Bhadelia, A., Jiang, X., & Arreola-Ornelas, H. (2020). Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. In *Enfermería: Cuidados Humanizados* (Vol. 8, Issue 4). <http://www.who.int/cancer/publications/palliative-care-atlas/en/>

Keluarga sering kali berada di garis depan dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada orang yang mereka cintai. Penelitian yang dilakukan oleh Tripodoro et al., (2024) menjelaskan bahwa keluarga merupakan sumber daya dalam

merawat pasien, pembuat keputusan, melakukan komunikasi terbuka dengan keluarga lainnya, menerima beban perawatan dan menerima mandat sosial budaya.

Beban emosional dan psikologis yang mereka tanggung dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan dukungan yang efektif. Dalam perjalanan penyakit terminal, keluarga pasien sering kali menghadapi tantangan yang berat, misalnya terkait finansial, fatigue, stres, ansietas, kondisi kesehatan yang memburuk, isolasi sosial, tantangan pekerjaan, konflik keluarga ataupun kurangnya pengetahuan terkait kondisi pasien (Biney et al., 2024). Oleh karena itu, dukungan psikologis kepada keluarga menjadi komponen penting dalam perawatan paliatif. Kesenjangan yang diidentifikasi pasien dan keluarga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4: Kesenjangan yang diidentifikasi oleh pasien dan keluarga dalam perawatan kanker stadium lanjut.



Sumber gambar: Ahmed S, Naqvi SF, Sinnarajah A, et al. Patient and caregiver experiences with advanced cancer care: a qualitative study informing the development of an early palliative care pathwayBMJ. Supportive & Palliative Care. 2020;14:e790–e797.

Dalam konteks inilah, dukungan psikologis memainkan peran penting dalam membantu keluarga mengembangkan strategi koping yang sehat dan memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi mereka. Bab pada buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif yang menawarkan wawasan dan panduan praktis untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dukungan psikologis, diharapkan keluarga dengan pasien paliatif dapat merasa lebih siap dan didukung dalam menjalani peran mereka.

C. Peran keluarga dalam perawatan paliatif

Peran keluarga dalam perawatan paliatif sangat penting karena anggota keluarga sering kali berperan sebagai pemberi perawatan utama dan pemberi sistem pendukung emosional bagi pasien yang menghadapi penyakit serius. Keterlibatan ini tidak hanya memengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, tetapi juga secara signifikan berdampak pada kesejahteraan pengasuh keluarga itu sendiri. Literatur menyoroti beberapa aspek kunci dari peran keluarga dalam perawatan paliatif, yang menekankan pentingnya dukungan, edukasi, dan komunikasi.

1. Tanggung jawab pengasuhan keluarga (*family caregiving responsibilities*)

Anggota keluarga sering kali mengambil tanggung jawab pengasuhan yang substansial dalam pengaturan perawatan paliatif. Mereka membantu dalam kegiatan sehari-hari, mengelola pengobatan, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pengasuh keluarga sering melakukan tugas-tugas penting seperti memberikan obat, memberikan perawatan pribadi, dan mengoordinasikan layanan perawatan kesehatan (McCauley et al., 2023). Keterlibatan langsung ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Namun, tuntutan yang dibebankan kepada keluarga dapat menyebabkan ketegangan fisik dan emosional yang signifikan sehingga membutuhkan sistem pendukung yang memadai untuk membantu mereka mengatasinya (Ibrahim et al., 2024; Kochuvilayil & Varma, 2024).

2. Pemberian dukungan emosi dan psikologis (*emotional and psychological support*)

Dukungan emosional dan psikologis yang diberikan oleh anggota keluarga sangat penting dalam perawatan paliatif. Keluarga sering kali menjadi sumber utama kenyamanan dan ketenangan bagi pasien serta membantu mereka menghadapi tantangan emosional yang terkait dengan penyakit serius (Ünlü et al., 2024; Zhang et al., 2023). Penelitian telah menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang kuat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi perasaan terisolasi dan cemas (Ibrahim et al., 2024). Selain itu, pertukaran emosional antara pasien dan pengasuh mereka dapat menumbuhkan ketahanan, sehingga memungkinkan keluarga untuk mengatasi tekanan pengasuhan secara lebih efektif (McCauley et al., 2023).

3. Komunikasi dan pengambilan keputusan

Komunikasi yang efektif antara anggota keluarga dan penyedia layanan kesehatan sangat penting dalam perawatan paliatif. Keluarga sering kali memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pilihan pengobatan dan preferensi perawatan (Lipsitz et al., 2024; Kurtgöz & Edis, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga secara aktif terlibat dalam diskusi tentang perawatan, maka akan menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara perawatan dengan nilai dan keinginan pasien (White et al., 2024; Fernandes et al., 2023). Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien secara keseluruhan (Lalani et al., 2024; Rungg & Schiefermeier-Mach, 2023).

4. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan untuk pengasuh keluarga sangat penting dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang efektif. Banyak anggota keluarga yang melaporkan bahwa mereka merasa tidak siap dengan tanggung jawab yang mereka hadapi, sehingga menyoroti perlunya intervensi pendidikan yang ditargetkan (Mendes et al., 2024). Program yang membekali pengasuh dengan pengetahuan tentang perawatan paliatif, manajemen gejala, dan strategi mengatasi masalah dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi mereka dalam peran pengasuhan. Edukasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemberi asuhan, tetapi juga berdampak positif pada hasil akhir pasien dengan memastikan bahwa asuhan diberikan secara efektif dan penuh kasih.

5. Sistem dukungan dan sumber daya

Pembentukan sistem dukungan dan sumber daya untuk pengasuh keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam perawatan paliatif. Akses ke sumber daya masyarakat, fasilitas perawatan, dan kelompok pendukung dapat meringankan beban pengasuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Ibrahim et al., 2024; Ünlü et al., 2024). Penelitian telah menunjukkan bahwa keluarga yang memanfaatkan sumber daya ini mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih baik (Zhang et al., 2023; Lalani et al., 2024). Selain itu, mengintegrasikan pendekatan asuhan yang berpusat pada keluarga ke dalam praktik asuhan paliatif dapat membantu memenuhi kebutuhan yang unik dari tiap keluarga, membina lingkungan yang lebih suportif baik bagi pasien maupun pemberi asuhan (McCauley et al., 2023).

Kesimpulannya, peran keluarga dalam asuhan paliatif memiliki banyak aspek, meliputi tanggung jawab pengasuhan, dukungan emosional, komunikasi, edukasi, dan akses terhadap sumber daya. Mengenali dan meningkatkan peran

ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan bagi pasien dan kesejahteraan keluarga mereka. Dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai, penyedia layanan kesehatan dapat memberdayakan keluarga untuk menghadapi tantangan asuhan paliatif secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

D. Dampak emosional & psikologis bagi keluarga pasien paliatif

Keluarga sering mengalami peningkatan kecemasan dan depresi saat mereka menghadapi tantangan merawat orang tercinta yang sakit parah yang dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Wang, 2024). Dampak emosional dan psikologis pada keluarga pasien paliatif sangat besar dan beragam. Keluarga sering mengalami berbagai emosi, termasuk kecemasan, ketakutan, dan rasa ketidakmampuan, terutama ketika mereka tidak siap untuk mengambil peran sebagai pengasuh.

Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan sikap negatif terhadap perawatan paliatif di rumah, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pengalaman traumatis selama proses perawatan (Krisdianto et al., 2024). Beban emosional diperparah ketika anggota keluarga merasa bahwa mereka tidak dibekali untuk memberikan dukungan yang diperlukan yang dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan tertekan (Krisdianto et al., 2024; Fernandes et al., 2023).

Selain itu, dinamika pengasuhan dalam lingkungan paliatif sering kali mengakibatkan tekanan psikologis yang signifikan pada anggota keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pengasuh keluarga sering kali mengalami kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan kelelahan emosional dan penurunan kesehatan mental mereka sendiri (Fernandes et al., 2023; Ibrahim et al., 2024). Dampak emosional tidak hanya merupakan konsekuensi dari tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga berasal dari kesedihan dan antisipasi kehilangan yang terkait dengan kematian orang yang dicintai (Nyirenda et al., 2024; McCauley et al., 2023). Keluarga sering kali mendapati diri mereka menavigasi emosional yang kompleks, di mana mereka harus menyeimbangkan perasaan duka mereka sendiri dengan kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada pasien (McCauley et al., 2023).

Selain itu, kualitas komunikasi dan dukungan dari tenaga kesehatan profesional memainkan peran penting dalam mengurangi dampak emosional pada keluarga. Komunikasi yang efektif dapat membantu keluarga merasa lebih terlibat dalam proses perawatan, sehingga mengurangi perasaan tidak berdaya dan cemas (Ibrahim et al., 2024). Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika penyedia layanan kesehatan melibatkan keluarga dalam diskusi tentang tujuan perawatan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, hal ini akan meningkatkan

kepuasan dan kesejahteraan emosional bagi pasien dan keluarganya (Lalani et al., 2024). Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat memperburuk perasaan terisolasi dan tertekan di antara anggota keluarga (Lalani et al., 2024).

Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada pengalaman pengasuhan langsung. Keluarga sering melaporkan dampak jangka panjang, termasuk kesedihan yang berkepanjangan dan perubahan dalam dinamika keluarga saat mereka menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai (Nyirenda et al., 2024). Beban emosional dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, yang mengarah pada peningkatan ketegangan dan konflik karena anggota keluarga berjuang untuk memproses kesedihan mereka dan mendukung satu sama lain (Popa et al., 2024).

Singkatnya, dampak emosional dan psikologis pada keluarga pasien paliatif cukup besar, ditandai dengan kecemasan, perasaan tidak mampu, dan kesedihan jangka panjang. Peran tenaga kesehatan profesional dalam menyediakan komunikasi dan dukungan yang efektif sangat penting dalam meringankan beberapa beban ini, menyoroti perlunya pendekatan holistik terhadap perawatan paliatif yang mempertimbangkan kesejahteraan pasien dan keluarganya.

E. Kebutuhan Keluarga dengan Pasien Paliatif

Kebutuhan keluarga pasien paliatif memiliki banyak aspek dan mencakup dimensi emosional, informasi, spiritual, praktis, dan sosial. Memahami kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memberikan dukungan komprehensif yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

1. Kebutuhan Emosional dan Psikologis

Keluarga sering kali mengalami tekanan emosional yang signifikan ketika mereka menghadapi tantangan dalam merawat orang yang mereka cintai dalam perawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengasuh keluarga menghadapi tingkat stres, kecemasan, dan beban emosional yang tinggi, terutama ketika mereka melihat kondisi orang yang mereka cintai memburuk (Ibrahim et al., 2024; Song et al., 2024). Ketegangan emosional diperparah dengan perasaan tidak berdaya dan takut akan kehilangan pasien yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan emosional ini melalui intervensi yang mendukung, seperti konseling dan sumber daya kesehatan mental, yang dapat membantu mengurangi ketegangan pengasuh dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Ibrahim et al., 2024; Lalani et al., 2024).

2. Kebutuhan akan informasi

Akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi pasien dan proses asuhan paliatif merupakan kebutuhan yang sangat penting

bagi keluarga. Penelitian telah menunjukkan bahwa pengasuh keluarga sering kali bergantung pada tenaga kesehatan profesional untuk mendapatkan panduan tentang perkembangan penyakit dan pilihan perawatan (Zhang et al., 2023; Fernandes et al., 2023). Kebutuhan akan informasi ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pengaturan perawatan, baik di rumah atau di fasilitas kesehatan (Zhang et al., 2023). Menyediakan sumber daya edukasi dan komunikasi yang jelas dapat memberdayakan keluarga dan memfasilitasi transisi yang lebih lancar ke dalam perawatan paliatif, yang pada akhirnya meningkatkan strategi koping mereka (Ibrahim et al., 2024; Ünlü et al., 2024).

3. Kebutuhan spiritual

Perawatan spiritual adalah aspek penting lain dari dukungan bagi keluarga dalam lingkungan paliatif. Para pengasuh sering kali mencari bimbingan spiritual untuk mengatasi gejolak emosi yang terkait dengan penyakit orang yang mereka cintai (Kurtgöz & Edis, 2023). Mereka mungkin menginginkan hubungan yang penuh kasih dengan penyedia layanan kesehatan yang dapat menawarkan empati dan pengertian selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Memenuhi kebutuhan spiritual dapat menumbuhkan harapan dan ketahanan di antara anggota keluarga, sehingga memungkinkan mereka untuk menemukan makna dalam peran pengasuhan mereka (Kurtgöz & Edis, 2023).

4. Kebutuhan layanan praktik (practical needs)

Keluarga juga menghadapi tantangan praktis, termasuk kebutuhan akan bantuan dalam tugas-tugas pengasuhan sehari-hari dan menavigasi sistem perawatan kesehatan. Banyak pengasuh melaporkan bahwa mereka merasa kewalahan dengan tanggung jawab dalam memberikan perawatan, yang dapat mencakup pemberian obat, mengelola gejala, dan berkoordinasi dengan penyedia layanan kesehatan (Nyirenda et al., 2024). Layanan dukungan, seperti perawatan di rumah dan bantuan kesehatan di rumah, dapat meringankan sebagian beban ini, sehingga keluarga dapat fokus pada dukungan emosional dan waktu berkualitas dengan orang yang mereka cintai (Ibrahim et al., 2024; Lalani et al., 2024).

5. Kebutuhan dukungan sosial

Dukungan sosial memainkan peran penting dalam kesejahteraan keluarga yang merawat pasien paliatif. Penelitian menyoroti pentingnya sumber daya komunitas dan jaringan pendukung, yang dapat memberikan bantuan emosional dan praktis (Ünlü et al., 2024; McCauley et al., 2023). Keluarga mendapat manfaat dari berhubungan dengan pengasuh lain yang memiliki pengalaman yang sama, karena hal ini dapat mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan strategi

penanggulangan (McCauley et al., 2023). Penyedia layanan kesehatan harus memfasilitasi akses ke kelompok pendukung dan sumber daya masyarakat untuk memperkuat tatanan sosial di sekitar keluarga dalam perawatan paliatif.

Singkatnya, kebutuhan keluarga pasien paliatif sangat beragam dan membutuhkan pendekatan holistik dalam perawatan. Memenuhi kebutuhan emosional, informasi, spiritual, praktis, dan dukungan sosial dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya selama fase kehidupan yang penuh tantangan ini.

F. Strategi Pemberian Dukungan untuk Keluarga Pasien Paliatif

Strategi dukungan untuk keluarga pasien paliatif memiliki banyak aspek dan mencakup berbagai dimensi perawatan, termasuk dukungan emosional, psikologis, dan praktis. Strategi-strategi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya selama masa-masa sulit yang terkait dengan penyakit serius. Literatur menyoroti beberapa area utama dimana dukungan dapat diimplementasikan secara efektif.

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan membentuk tim asuhan paliatif multidisiplin yang memberikan dukungan komprehensif kepada keluarga. Tim-tim ini biasanya terdiri dari para profesional kesehatan seperti dokter, perawat, pekerja sosial, dan psikolog, yang bekerja secara kolaboratif untuk memenuhi beragam kebutuhan pasien dan keluarganya. Sebagai contoh, di negara-negara maju, integrasi layanan Perawatan Paliatif Spesialis (Specialist Palliative Care/SPC) telah terbukti secara signifikan meningkatkan akses terhadap perawatan dan dukungan bagi keluarga, sehingga mereka dapat menerima intervensi dan bimbingan yang tepat waktu di sepanjang proses perawatan paliatif (Krisdianto et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi manajemen gejala yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan lingkungan yang mendukung di mana keluarga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pilihan perawatan dan preferensi akhir hayat (Ishak Tayoob et al., 2024).

Selain itu, intervensi psikososial telah diidentifikasi sebagai komponen penting dari dukungan keluarga dalam pengaturan perawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerima dukungan psikososial mengalami peningkatan kualitas hidup dan berkurangnya tekanan pada pengasuh (Lalani et al., 2024). Program-program seperti Project ENABLE yang menyediakan pelatihan perawatan paliatif untuk pengasuh keluarga, telah menunjukkan keefektifan dalam meningkatkan akses ke perawatan dan meringankan beban emosional yang terkait dengan pengasuhan (Lalani et al., 2024). Intervensi semacam itu menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional keluarga, yang secara signifikan dapat berdampak pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan selama proses pengasuhan.

Selain dukungan profesional, dukungan timbal balik antara pasien dan pengasuh keluarga memainkan peran penting dalam pengalaman perawatan paliatif. Penelitian telah menunjukkan bahwa pertukaran emosional antara pasien dan pengasuhnya dapat menumbuhkan ketahanan dan strategi penanggulangan, sehingga memungkinkan keluarga untuk menavigasi kompleksitas perawatan paliatif dengan lebih efektif (McCauley et al., 2023). Dukungan timbal balik ini tidak hanya meningkatkan hubungan emosional antara pasien dan pengasuh, tetapi juga berkontribusi pada pendekatan perawatan yang lebih holistik yang mengakui saling ketergantungan dinamika keluarga dalam konteks paliatif.

Selain itu, integrasi sumber daya berbasis komunitas dan jaringan dukungan sangat penting bagi keluarga yang menghadapi tantangan perawatan paliatif. Inisiatif pelibatan masyarakat yang menghubungkan keluarga dengan layanan dukungan yang bersifat lokal dapat memberikan bantuan tambahan, termasuk perawatan, konseling, dan dukungan spiritual (Dasat & Anggraini, 2023). Sumber daya ini sangat penting terutama di daerah pedesaan atau daerah yang kurang terlayani di mana akses ke perawatan paliatif mungkin terbatas. Dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat, keluarga dapat meningkatkan mekanisme koping mereka dan mengurangi perasaan terisolasi selama proses perawatan.

Strategi koping yang digunakan oleh keluarga juga memainkan peran penting dalam mengelola stres yang terkait dengan perawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga sering menggunakan berbagai mekanisme koping, termasuk mencari dukungan emosional, terlibat dalam strategi koping aktif, dan beralih ke spiritualitas untuk mendapatkan kenyamanan. Memahami strategi koping ini sangat penting bagi penyedia layanan kesehatan, karena memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dukungan mereka untuk memenuhi kebutuhan unik setiap keluarga. Dengan membina lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka dan ekspresi emosional, tenaga kesehatan profesional dapat membantu keluarga menavigasi lanskap emosional perawatan paliatif dengan lebih efektif.

Waktu pelaksanaan intervensi asuhan paliatif merupakan faktor penting lain yang memengaruhi dukungan keluarga. Identifikasi dini dan rujukan ke layanan asuhan paliatif telah terbukti meningkatkan komunikasi dan dukungan bagi keluarga, sehingga mereka dapat terlibat secara lebih bermakna dalam proses asuhan (Ishak Tayoob et al., 2024). Ketika keluarga dilibatkan sejak dini, mereka dapat lebih memahami prognosis dan berpartisipasi dalam diskusi tentang tujuan perawatan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kepuasan atas perawatan yang diterima (Ishak Tayoob et al., 2024). Pendekatan proaktif ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang tepat terkait perawatan orang yang mereka cintai.

Sebagai kesimpulan, strategi dukungan bagi keluarga pasien paliatif sangat beragam dan mencakup berbagai intervensi yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan emosional, psikologis, dan praktis para pengasuh. Tim asuhan paliatif multidisiplin, intervensi psikososial, dinamika dukungan timbal balik, sumber daya komunitas, strategi koping, dan intervensi yang tepat waktu, semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga selama perjalanan asuhan paliatif. Dengan mengenali dan menerapkan strategi-strategi ini, penyedia layanan kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan bagi pasien dan keluarga mereka, memastikan bahwa mereka menerima dukungan komprehensif yang diperlukan selama masa-masa yang penuh tantangan ini.

G. Peran perawat dalam memberikan dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif

Peran perawat dalam memberikan dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif sangat penting, karena mereka berperan sebagai pengasuh utama (*primary caregivers*) dan pendamping selama masa-masa sulit. Tanggung jawab mereka meliputi dukungan emosional, edukasi, komunikasi, dan koordinasi perawatan, yang semuanya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya.

1. Dukungan emosi (*Emotional Support*)

Perawat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada keluarga, membantu mereka mengatasi stres dan kesedihan yang terkait dengan penyakit terminal. Mereka sering kali bertindak sebagai sosok yang menghibur, memberikan kepastian dan empati kepada anggota keluarga yang mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, atau kesedihan terkait kondisi orang yang mereka cintai (Hawari & Albashtawy, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketika perawat membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, mereka dapat memenuhi kebutuhan emosional mereka dengan lebih baik, membina lingkungan di mana anggota keluarga merasa aman untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran mereka (Cohen et al., 2023). Hubungan emosional ini sangat penting dalam mengurangi perasaan terisolasi dan ketidakberdayaan yang sering dihadapi keluarga selama perawatan paliatif.

2. Pendidikan dan Informasi

Perawat bertanggung jawab untuk mengedukasi keluarga mengenai proses asuhan paliatif, termasuk manajemen gejala, pilihan pengobatan, dan apa yang diharapkan seiring dengan perkembangan penyakit. Memberikan informasi yang jelas dan akurat membantu keluarga membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kenyataan perawatan di akhir hayat (Li et al., 2024); Jin & Kang, 2024). Studi menunjukkan bahwa ketika keluarga mendapat informasi yang cukup, mereka mengalami lebih sedikit kecemasan dan

lebih mungkin untuk terlibat dalam perencanaan perawatan di masa depan, yang dapat meningkatkan rasa kontrol dan kebebasan mereka selama masa-masa sulit (Cohen et al., 2023).

3. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan landasan praktik keperawatan dalam asuhan paliatif. Perawat memfasilitasi diskusi antara keluarga dan tim kesehatan, memastikan bahwa kekhawatiran dan preferensi anggota keluarga didengar dan dihargai (Hiratsuka et al., 2024; Kaufman et al., 2024). Peran ini sangat penting dalam situasi yang kompleks di mana keluarga mungkin kesulitan memahami jargon medis atau merasa kewalahan dengan informasi yang disampaikan kepada mereka. Dengan bertindak sebagai perantara, perawat dapat membantu mengklarifikasi kesalahpahaman dan memastikan bahwa keluarga secara aktif terlibat dalam keputusan perawatan, yang dapat meningkatkan ketahanan emosional mereka (Wilkin et al., 2024; Elibol & Akpinar, 2023).

4. Koordinasi perawatan (*Coordination of care*)

Perawat juga mengoordinasikan perawatan di antara berbagai penyedia layanan kesehatan, memastikan bahwa keluarga menerima dukungan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini termasuk menghubungkan keluarga dengan pekerja sosial, pendeta, dan spesialis lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan spiritual yang lebih luas dari unit keluarga (Häusermann et al., 2023). Dengan memfasilitasi akses ke sumber daya ini, perawat dapat membantu keluarga menavigasi kompleksitas perawatan paliatif, mengurangi beban mereka dan meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan (Hussein et al., 2024) (Hussein et al., 2024; Uçar et al., 2023).

5. Menghadapi tantangan psikologis

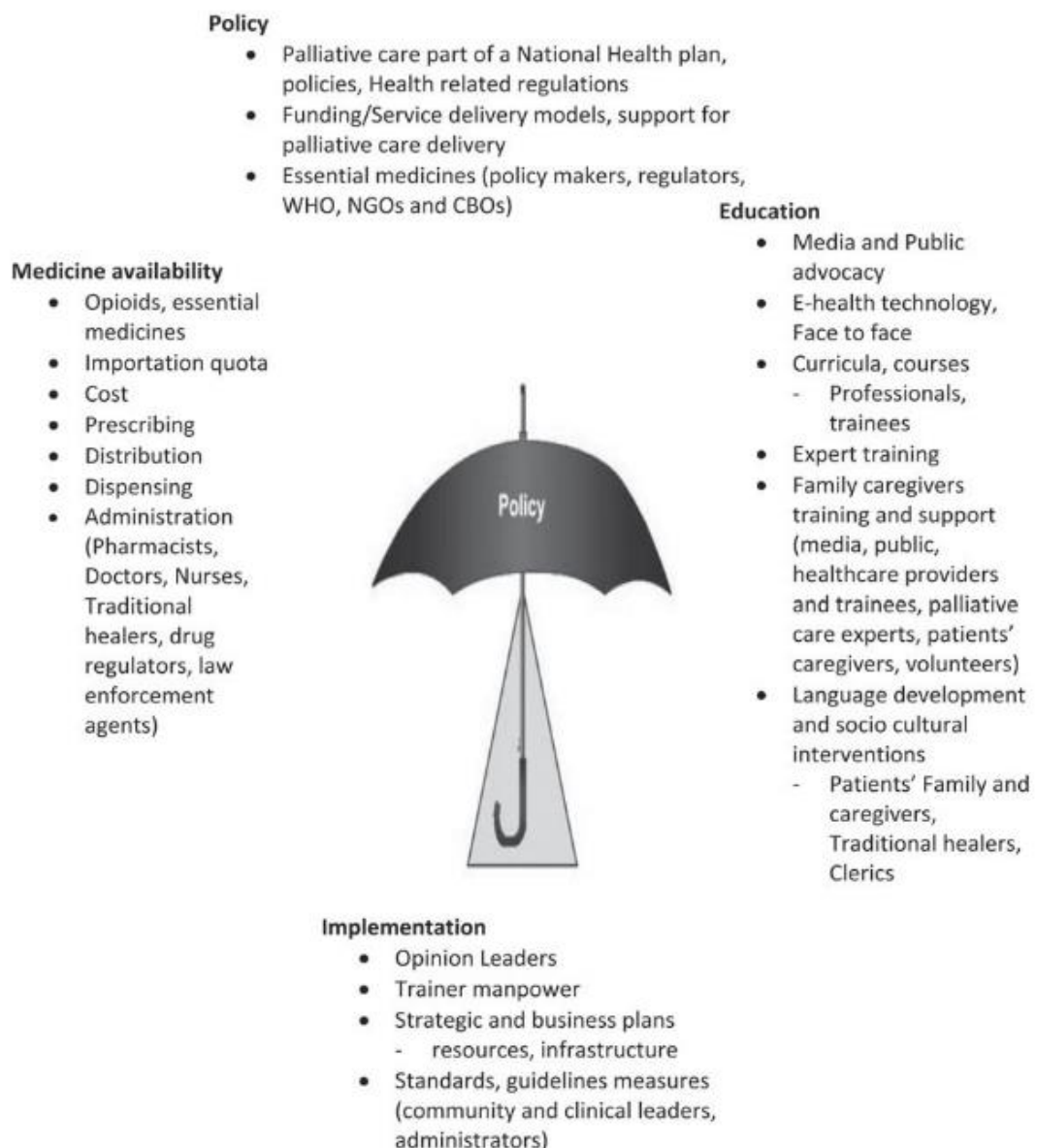
Perawat dilatih untuk mengenali dan mengatasi tantangan psikologis yang dihadapi oleh keluarga, termasuk kesedihan, depresi, dan kecemasan. Mereka dapat menyediakan strategi dan sumber daya untuk membantu keluarga mengelola perasaan-perasaan tersebut, yang merupakan hal yang umum dalam konteks asuhan paliatif (Bassah et al., 2023; Mansour Mohammed et al., 2023). Selain itu, perawat dapat mengadvokasi dukungan kesehatan mental bila diperlukan, memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap konseling dan intervensi terapeutik lainnya yang dapat membantu penyembuhan emosional mereka (Chan & Yu, 2024).

Singkatnya, perawat memainkan peran yang beragam dalam memberikan dukungan psikologis bagi keluarga pasien paliatif. Melalui dukungan emosional, edukasi, komunikasi yang efektif, koordinasi perawatan, dan mengatasi

tantangan psikologis, perawat secara signifikan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga selama salah satu masa tersulit dalam hidup mereka. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, tetapi juga mendukung keluarga dalam mengatasi beban emosional dan psikologis yang terkait dengan penyakit terminal.

Yemoh et al., (2022) mengilustrasikan sebuah pendekatan yang terintegrasi, berbasis kebijakan, edukasi, ketersediaan obat, dan implementasi berbasis masyarakat untuk memastikan akses yang luas dan efektif kepada perawatan paliatif, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5: Modifikasi model pemberian layanan paliatif



Sumber: Yemoh, V., Olayemi, L. O., & Abraham, J. A. (2022). Preferences of quality delivery of palliative care among cancer patients in low- and middle-income countries: A review. *Palliative and Supportive Care*, 20(2), 275–282. <https://doi.org/10.1017/S1478951521000456>

H. Membangun resiliensi pada keluarga dengan pasien paliatif

Membangun ketahanan dalam keluarga dengan pasien paliatif merupakan aspek penting dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan emosional dan praktis yang terkait dengan penyakit serius. Ketangguhan, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang meskipun menghadapi kesulitan, dapat dipupuk melalui berbagai strategi yang melibatkan dukungan emosional, komunikasi yang efektif, dan integrasi mekanisme koping.

Salah satu elemen dasar dalam membina ketangguhan adalah pembentukan lingkungan yang mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerima dukungan emosional dan sosial yang memadai akan lebih siap untuk menangani tekanan pengasuhan dan kehilangan orang yang dicintai (Zhang et al., 2023; Lau et al., 2021). Dukungan ini dapat berasal dari tenaga kesehatan profesional, sumber daya masyarakat, dan jaringan pertemanan (Zanatta et al., 2020; Alodhialah et al., 2024). Ketika tenaga kesehatan dilatih untuk mengelola respons emosional mereka sendiri dan mengembangkan ketahanan, mereka akan lebih mungkin memberikan perawatan penuh kasih yang memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya (Hubik et al., 2021; Arantzamendi et al., 2024).

Komunikasi yang efektif adalah komponen penting lainnya dalam membangun ketahanan. Dialog terbuka antara anggota keluarga dan penyedia layanan kesehatan dapat memfasilitasi pemahaman dan membantu keluarga menavigasi keputusan medis yang kompleks (Maus et al., 2024). Penelitian telah menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas tentang kondisi dan prognosis pasien dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian, sehingga keluarga dapat fokus pada interaksi yang bermakna dengan orang yang mereka cintai (Lau et al., 2021; Lee et al., 2024). Selain itu, mendorong keluarga untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran mereka dapat memperkuat ikatan emosional mereka dan meningkatkan strategi penanggulangan kolektif mereka (Zhang et al., 2023).

Spiritualitas dan jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan ketangguhan di antara keluarga yang menghadapi perawatan paliatif. Keyakinan spiritual dapat memberikan kenyamanan dan makna selama masa-masa sulit, sementara jaringan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan praktis dan emosional (Lau et al., 2021). Mendorong keluarga untuk terlibat dengan komunitas spiritual atau kelompok pendukung mereka dapat meningkatkan mekanisme koping mereka dan menyediakan sumber daya tambahan untuk menavigasi perjalanan perawatan paliatif (Cetin & Ozen, 2024).

Kesimpulannya, membangun ketahanan dalam keluarga dengan pasien paliatif membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup dukungan emosional, komunikasi yang efektif, strategi koping, dan integrasi spiritualitas dan jaringan sosial. Dengan membina ketahanan, kita dapat membantu keluarga menavigasi

kompleksitas perawatan paliatif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka dan perawatan yang mereka berikan kepada orang yang mereka cintai.

I. Penutup

Dukungan keluarga merupakan komponen krusial dalam keberhasilan perawatan paliatif. Keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga dukungan informasional, instrumental, dan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Mereka berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan spiritual pasien, membantu dalam mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di sekitar.

Dukungan emosional dari keluarga, seperti empati, perhatian, dan kasih sayang, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini membantu pasien merasa diperhatikan dan dihargai, yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas psikologis mereka. Namun, keluarga juga menghadapi berbagai hambatan, seperti beban emosional dan fisik, serta kesulitan dalam mengakses sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang memadai dari tim kesehatan.

Edukasi dan konseling dari tim kesehatan dapat membantu keluarga dalam memberikan dukungan yang lebih efektif. Keluarga perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang perawatan paliatif, termasuk pengenalan gejala, pengambilan keputusan, dan modifikasi lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam keseluruhan, peran keluarga dalam perawatan paliatif adalah tidak tergantikan. Dukungan yang mereka berikan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup pasien, tetapi juga membantu pasien dan keluarga mereka menghadapi tantangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat dan mendukung peran keluarga dalam proses perawatan paliatif melalui edukasi, bantuan praktis, dan dukungan emosional yang berkelanjutan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pasien paliatif menerima perawatan yang holistik dan dukungan yang menyeluruh, sehingga mereka dapat menjalani sisa hidup mereka dengan lebih nyaman dan bermakna.

Referensi

- Alodhialah, A. M., Almutairi, A. A., & Almutairi, M. (2024). Exploring Nurses' Emotional Resilience and Coping Strategies in Palliative and End-of-Life Care Settings in Saudi Arabia: A Qualitative Study. *Healthcare (Switzerland)*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/healthcare12161647>
- Arantzamendi, M., Sapeta, P., Belar, A., & Centeno, C. (2024). How palliative care professionals develop coping competence through their career: A grounded theory. *Palliative Medicine*, 38(3), 284–296. <https://doi.org/10.1177/02692163241229961>
- Bassah, N., Vaughn, L., & Santos Salas, A. (2023). Nurse-led adult palliative care models in low- and middle-income countries: A scoping review. *Journal of Advanced Nursing*, 79(11), 4112–4126. <https://doi.org/10.1111/jan.15646>
- Biney, A., Sarfo, J. O., Poku, C. A., Deegbe, D. A., Atibila, F., Nachinab, G. T., Anaba, E., Dzansi, G., & Attafuah, P. Y. A. (2024). Challenges and Coping Strategies When Caring for Terminally Ill Persons With Cancer: Perspectives of Family Caregivers. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01518-z>
- Cetin, Z., & Ozen, B. (2024). Investigating spiritual care perceptions and religious coping methods among the relatives of terminally ill patients during the COVID-19 pandemic: the case of Turkey. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01463-x>
- Chan, K. M., & Yu, L. B. (2024). *The dilemma of palliative care nurses: A phenomenological inquiry into their lived experience with humanistic care*. 1–14.
- Clelland, D., van Steijn, D., Whitelaw, S., Connor, S., Centeno, C., & Clark, D. (2020). Palliative Care in Public Policy: Results from a Global Survey. *Palliative Medicine Reports*, 1(1), 183–190. <https://doi.org/10.1089/pmr.2020.0062>
- Cohen, M. G., Althouse, A. D., Arnold, R. M., White, D., Chu, E., Rosenzweig, M., Smith, K. J., & Schenker, Y. (2023). Primary Palliative Care Improves Uptake of Advance Care Planning Among Patients With Advanced Cancers. *JNCCN Journal of the National Comprehensive Cancer Network*, 21(4), 383–390. <https://doi.org/10.6004/jnccn.2023.7002>
- Connor, S., Morris, C., Jaramilo, E., Harding, R., Cleary, J., Haste, B., Knaul, F., Lima, L., Krakauer, E., Bhadelia, A., Jiang, X., & Arreola-Ornelas, H. (2020). Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. In *Enfermería: Cuidados Humanizados* (Vol. 8, Issue 4). <http://www.who.int/cancer/publications/palliative-care-atlas/en/>
- Dasat, M., & Anggraini, D. (2023). Family Support in Telenursing to Undergo Palliative Care for Cancer Patients. *Journal of Community Engagement in Health*, 6(1), 154–158. <https://doi.org/10.30994/jceh.v6i1.445>

- Elibol, N., & Akpinar, A. (2023). Attitudes of Senior Nursing Students Towards Ethical Issues for Palliative Care. *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 13(2), 419–427. <https://doi.org/10.31020/mutfd.1259658>
- Fernandes, J. B., Domingos, J., Castro, C., Simões, A., Fernandes, S., Almeida, A. S., Bernardes, C., Miranda, L., Risso, S., Ferreira, R., Baixinho, C. L., Silvestre, M., & Godinho, C. (2023). Needs and expectations of family caregivers of cancer patients in palliative care: A study protocol. *Frontiers in Psychology*, 13(January), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1071711>
- Häusermann, S., Huber, E., Meichtry, A., Gautschi, F., Ris, I., & Deufert, D. (2023). Effects of high-fidelity simulation on self-efficacy in undergraduate nursing education regarding family systems care and early palliative care. *Journal of Nursing Education and Practice*, 13(12), 1. <https://doi.org/10.5430/jnep.v13n12p1>
- Hawari, N. M., & Albashtawy, M. (2023). *Critical Care Nurses Knowledge , Practice , Facilitators , and Barriers of Palliative Care : A Scoping Review*. 1–12.
- Hiratsuka, Y., Suh, S. Y., & Yoon, S. J. (2024). Comparison of Simplified Palliative Prognostic Index and Palliative Performance Scale in Patients with Advanced Cancer in a Home Palliative Care Setting. *Journal of Palliative Care*, 39(3), 194–201. <https://doi.org/10.1177/08258597231214896>
- Hubik, D. J., O’Callaghan, C., & Dwyer, J. (2021). Strong emotional reactions for doctors working in palliative care: Causes, management and impact. A qualitative study. *Psycho-Oncology*, 30(9), 1582–1589. <https://doi.org/10.1002/pon.5731>
- Hussein, N. S., Mohamed, M. A., & Ahmed, R. A. (2024). *Enhancing palliative care for oncology patients : The effect of educational intervention on nurses competency and Attitude*. 3, 1171–1190.
- Ibrahim, A. M., Zaghamir, D. E. F., Sultan Sultan, H. M., Ibrahim, F. M., & Abdel-Aziz, H. R. (2024). Optimizing geriatric palliative care in Egypt: Comprehensive patient and family perspectives. *Palliative and Supportive Care*. <https://doi.org/10.1017/S1478951524000221>
- Ishak Tayoob, M., Rayala, S., Doherty, M., Singh, H. B., Alimelu, M., Lingaldinna, S., & Palat, G. (2024). Palliative Care for Newborns in India: Patterns of Care in a Neonatal Palliative Care Program at a Tertiary Government Children’s Hospital. *Health Services Insights*, 17, 1–8. <https://doi.org/10.1177/11786329231222858>
- Jin, E., & Kang, H. (2024). Nursing Students’ Volunteer Experiences of Interacting with Children Receiving Pediatric Palliative Care: A Qualitative Study. *Children*, 11(11), 1–13. <https://doi.org/10.3390/children11111391>
- Kaufman, B. G., Holland, D. E., Vanderboom, C. E., Ingram, C., Wild, E. M., Dose, A. M., Stiles, C., Gustavson, A. M., Chun, A., Langan, E. M., Baer-Benson, H. A., Mandrekar,

- J., & Griffin, J. M. (2024). Implementation Costs of Technology-Enhanced Transitional Palliative Care for Rural Caregivers. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, 41(1), 38–44. <https://doi.org/10.1177/10499091231156145>
- Kochuvilayil, A., & Varma, R. P. (2024). Understanding caregiver burden and quality of life in Kerala's primary palliative care program: a mixed methods study from caregivers and providers' perspectives. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02155-x>
- Krisdianto, B. F., Dahlia, D., & Waluyo, A. (2024). Embracing family presence: exploring the reasons for family decision-making dependence on in-hospital palliative care for cancer patients. *Healthcare in Low-Resource Settings*. <https://doi.org/10.4081/hls.2024.12097>
- Kurtgöz, A., & Edis, E. K. (2023). Spiritual care from the perspective of family caregivers and nurses in palliative care: a qualitative study. *BMC Palliative Care*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01286-2>
- Lalani, N., Hamash, K., & Wang, Y. (2024). Palliative care needs and preferences of older adults with advanced or serious chronic illnesses and their families in rural communities of Indiana, USA. *Journal of Rural Health*, 40(2), 368–375. <https://doi.org/10.1111/jrh.12787>
- Lau, J., Khoo, A. M. G., Ho, A. H. Y., & Tan, K. K. (2021). Psychological resilience among palliative patients with advanced cancer: A systematic review of definitions and associated factors. *Psycho-Oncology*, 30(7), 1029–1040. <https://doi.org/10.1002/pon.5666>
- Lee, A., Wong, Y., & Seng Neo, X. (2024). Coping Mechanisms Among Patients with Terminal Illnesses. *KMAN Counseling and Psychology Nexus*, 2(1), 91–97. <https://doi.org/10.61838/kman.psychnexus.2.1.14>
- Li, X., Hu, S., Zhou, Y., Ying, X., & Wu, T. (2024). Impact of nurse-led palliative care on symptom management and life quality outcomes in elderly cancer patients: A retrospective study. *Medicine (United States)*, 103(40), e39817. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000039817>
- Lipsitz, J., Beveridge, M. S., & Maddox, K. (2024). Palliative Care for Dialysis-Dependent Pediatric Patients: A Survey of Providers, Nurses, and Caregivers. *Kidney360*, 5, 1669–1674. <https://doi.org/10.34067/KID.0000000000000558>
- Mansour Mohammed, M., El shamy, K., & Mohamed, H. (2023). Challenges Facing Hospital Based Nurses who Provide Palliative Care for Patients with Chronic and Serious Illness. *Mansoura Nursing Journal*, 10(2), 181–191. <https://doi.org/10.21608/mnj.2023.340380>
- Maus, K., Peusquens, F., Kriegsmann-Rabe, M., Matthias, J. K., Ateş, G., Jaspers, B., Geiser, F., & Radbruch, L. (2024). 'Not a panacea' – Expert perspectives on the concept of

- resilience and its potential for palliative care. *Palliative Care and Social Practice*, 18, 1–15. <https://doi.org/10.1177/26323524241254839>
- McCauley, R., Ryan, K., McQuillan, R., & Foley, G. (2023). Mutual support between patients and family caregivers in palliative care: A qualitative study. *Palliative Medicine*, 37(10), 1520–1528. <https://doi.org/10.1177/02692163231205130>
- Mendes, M. A., Janssen, D. J. A., & Marques, A. (2024). Integrating palliative care education in pulmonary rehabilitation: a randomized controlled study protocol. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01363-0>
- Nyirenda, C., Sagawa, J., & Chilinda, I. (2024). *Exploring Experiences of Palliative Care Patients' Guardians at Mzuzu Central Hospital Findings*: 1–16.
- Popa, M. V., Mîndru, D. E., Hizan, M., Gurzu, I. L., Anton-Păduraru, D. T., Ștreangă, V., Gurzu, B., Guțu, C., Elkan, E. M., & Duceac, L. D. (2024). Stress Factors for the Paediatric and Adult Palliative Care Multidisciplinary Team and Workplace Wellbeing Solutions. *Healthcare (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/healthcare12090868>
- Rungg, C., & Schiefermeier-Mach, N. (2023). Home-based palliative care services from the perspective of family caregivers: an evaluation of the Integrated Palliative Care model in Tyrol / Häusliche Palliativversorgung aus der Sicht der pflegenden Angehörigen - eine Evaluation des Modells Integriert. *International Journal of Health Professions*, 10(1), 24–36. <https://doi.org/10.2478/ijhp-2023-0004>
- Song, J., Ramlogan, L., Vergez, S., Davoudi, A., Sridharan, S., Cho, H., Stanley, J., McDonald, M. V., Bowles, K. H., Shang, J., Stone, P. W., & Topaz, M. (2024). The Paradox of Choice in Palliative Care Decision-Making in Managed Long-Term Care: A Qualitative Study. *Home Health Care Management and Practice*. <https://doi.org/10.1177/10848223241247197>
- Tripodoro, V. A., Veloso, V. I., Víbora Martín, E., Kodba-Čeh, H., Bakan, M., Rasmussen, B. H., Zambrano, S. C., Joshi, M., Hálfðánardóttir, S. Í., Ásgeirsdóttir, G. H., Romarheim, E., Haugen, D. F., McGlinchey, T., Yildiz, B., Barnestein-Fonseca, P., Goossensen, A., Lunder, U., & van der Heide, A. (2024). 'Someone must do it': multiple views on family's role in end-of-life care – an international qualitative study. *Palliative Care and Social Practice*, 18, 1–16. <https://doi.org/10.1177/26323524241260425>
- Uçar, Ö., Çelik, S., Karahan, E., & Altıntaş, S. (2023). Nursing care for symptoms seen in patients undergoing palliative surgery – a retrospective study. *European Journal of Clinical and Experimental Medicine*, 21(3), 582–589. <https://doi.org/10.15584/ejcem.2023.3.26>
- Ünlü, İ., Ulucan Şahin, C., Karataş, M., & Cantekin, Ö. F. (2024). "We Have Learned To Speak With Our Eyes": Reflections of the Pediatric Palliative Care Process on

- Family Life. *Karya Journal of Health Science*, 5(2), 69–76. <https://doi.org/10.52831/kjhs.1451425>
- Wang, C. (2024). Availability and Stability of Palliative Care for Family Members of Terminally Ill Patients in an Integrated Model of Health and Social Care. *BMC Palliative Care*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01475-7>
- White, S., Turbitt, E., Rogers, K., Tucker, K., McEwen, A., Best, M., Phillips, J. L., & Jacobs, C. (2024). A survey of genetic and palliative care health professionals' views of integrating genetics into palliative care. *European Journal of Human Genetics*, 32(1), 109–116. <https://doi.org/10.1038/s41431-023-01409-6>
- WHO. (2018). Why Palliative Care Is an Essential Function of Primary Health Care. *World Health Organization*, 1–20. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/palliative.pdf?sfvrsn=ecab9b11_2&ua=1
- Wilkin, K., Fang, M. L., & Sixsmith, J. (2024). Implementing advance care planning in palliative and end of life care: a scoping review of community nursing perspectives. *BMC Geriatrics*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-04888-4>
- Willemsen, A. M., Mason, S., Zhang, S., & Elsner, F. (2021). Status of palliative care education in Mainland China: A systematic review. *Palliative and Supportive Care*, 19(2), 235–245. <https://doi.org/10.1017/S1478951520000814>
- World Health Organization. (2020). *Palliative care*. <https://doi.org/10.1002/9781119293255.ch10>
- World Health Organization. (2023). *Palliative Care*. World Health Organisation. <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care>
- Yemoh, V., Olayemi, L. O., & Abraham, J. A. (2022). Preferences of quality delivery of palliative care among cancer patients in low- and middle-income countries: A review. *Palliative and Supportive Care*, 20(2), 275–282. <https://doi.org/10.1017/S1478951521000456>
- Zanatta, F., Maffoni, M., & Giardini, A. (2020). Resilience in palliative healthcare professionals: a systematic review. *Supportive Care in Cancer*, 28(3), 971–978. <https://doi.org/10.1007/s00520-019-05194-1>
- Zhang, X., Xu, T., Qin, Y., Wang, M., Li, Z., Song, J., Tang, Q., Wang, Z., Xu, L., Wu, L., & Yue, P. (2023). Exploring the needs and coping strategies of family caregivers taking care of dying patients at home: a field study. *BMC Palliative Care*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01315-0>

BAB IV

PENGELOLAAN NYERI PADA PASIEN PENYAKIT TERMINAL

A. Pendahuluan

Illness terminal penyakit terminal merupakan salah satu pelayanan paliatif yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, pengobatan nyeri dan gejala fisik lainnya, masalah psikososial dan spiritual (Kemenkes, 2023). Hal ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/Menkes/SK/VIII/2007 tentang penyelenggaraan pelayanan paliatif.

B. Penyakit Terminal/*Illess Terminal*

Illness terminal penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara memadai dan dapat mengakibatkan kematian. Yang termasuk penyakit terminal terdiri dari penyakit kanker atau penyakit jantung lanjut, trauma. Penyakit ini biasanya berbulan-bulan atau kurang. Pasien terminal setelah di diagnosa oleh dokter, memiliki pilihan untuk manajemen penyakit seperti perawatan lanjutan, perawatan rumah sakit bahkan bunuh diri yang dibantu dokter.

Hal ini akan mempengaruhi gaya hidup namun tergantung dari kondisi pasien itu sendiri baik sifat penyakit maupun keterbatasan hidup dari efek penyakit terminalnya. Biasanya pasien akan mengalami depresi atau kegelisahan yang terkait dengan kematian yang akan datang, dan keluarga kesulitan dengan beban psikologis juga. Intervensi psikologis dapat meringankan sebagian beban ini dan sering dimasukkan dalam perawatan paliatif.

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui indentifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain fisik, psikososial dan spiritual (Astutik, 2023; Putri, 2022) (WHO, 2018)). Perawatan paliatif diberikan kepada pasien terminal illness adalah untuk meredakan nyeri yang dirasakan serta keluhan-keluhan lainnya serta mengurangi gangguan emosi, sosial dan spiritual.

Jenis penyakit terminal diantaranya 1) Penyakit kanker, 2) Gagal Ginjal Kronis, 3) Multiple skelosis, 4) AIDS, 5) Diabetes Mellitus, 6) Akibat kecelakaan fatal, 7) Meningitis, 8) lainnya.

C. Nyeri pada Penyakit Terminal

Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dirasakan pasien dengan penyakit terminal. Nyeri adalah sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan ((PPNI, 2018), (AMA, 2010). Nyeri adalah apapun yang menyakitkan tubuh yang dikatakan individu yang mengalaminya, yang ada kapanpun individu mengatakannya (Bare, 2002)

Nyeri yang dirasakan akan terasa berat tergantung dari usia, jenis kelamin, kultur, makna nyeri, perhatian, ansietas, pengalaman masal lalu, pola koping, support keluarga dan sosial serta intensitas nyeri. Sifat nyeri pada penyakit terminal ada yang sifatnya akut ada juga kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang timbul secara perlahan – lahan, biasanya berlangsung dalam waktu cukup lama, yaitu lebih dari 6 bulan, sedangkan nyeri akut adalah nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, yang tidak melebihi 6 bulan dan di tandai adanya peningkatan tegangan otot.

Respon fisiologis terhadap nyeri diantaranya:

1. Stimulasi simpatik biasanya nyeri ringan, sedang, dan superficial yang biasanya ditandai dengan:
 - a. Dilatasi saluran bronkhial dan peningkatan respirasi rate,
 - b. Peningkatan heart rate,
 - c. Vasokonstriksi perifer,
 - d. Peningkatan nilai gula darah,
 - e. Diaphoresis,
 - f. Peningkatan kekuatan otot,
 - g. Dilatasi pupil, dan
 - h. Penurunan motilitas Gastrointestinal.
2. Stimulus Parasimpatik biasanya nyeri berat dan dalam ditandai dengan
 - a. Muka pucat,
 - b. Otot mengeras,
 - c. Penurunan *Heart Rate*,
 - d. Nafas cepat dan irreguler,
 - e. Nausea dan vomitus dan
 - f. Kelelahan dan keletihan.

D. Pengkajian Nyeri

Pengkajian nyeri dilakukan untuk mengetahui keluhan dan masalah yang dirasakan dengan langkah-langkah menurut (Yudiyanto, 2015), sebagai berikut :

1. Tanyakan terkait adanya Nyeri atau ketidaknyamanan saat pasien datang/di rawat maupun pada setiap pengkajian
2. Gunakan alat pengkajian nyeri yang valid
3. Lakukan pengkajian riwayat Nyeri menggunakan PQRST
 - a. *Provoking/Palliatif Factor* (faktor penyebab); tanyakan apa yang membuat Nyeri bertambah dan berkurang
 - b. *Quality/quantity*; meminta klien mendeskripsikan rasa Nyeri yang dirasakan dengan menggunakan kalimat sendiri
 - c. *Region; radiation* (lokasi dan penyebaran) Tanyakan dimana lokasi Nyeri?Apakah menyebar?apakah Nyeri yang dirasakan juga di bagian tubuh lainnya?
 - d. *Severity* (Keparahan); Scale; Meminta klien untuk menilai intensitas Nyeri menggunakan skala Nyeri, tanyakan berapa intensitas Nyeri saat istirahat?berapa intensitas Nyeri saat bergerak/aktifitas?
 - e. *Time of onset, duration and pattern* (waktu kejadian, lama, pola) Tanyakan kapan mulai Nyeri?berapa lama Nyeri berlangsung?apakah menetap?jika tidak, seberapa sering nyeri terjadi kalimat.

E. Pengukuran Nyeri

Pengukuran nyeri untuk mengetahui intensitas nyeri yang dirasakan menggunakan pengukuran nyeri seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), atau Verbal Rating Scale (VRS) .

1. NRS adalah instrumen yang terdiri dari garis berorientasi baik secara vertikal maupun horizontal. Nomor "1" yang terletak di bagian bawah skala, jika bentuk vertikal yang digunakan dan sisi kiri skala jika bentuk horizontal digunakan. Nomor "10" terletak di bagian atas skala, jika vertikal yang digunakan dan di sebelah kanan sisi skala, jika bentuk horizontal digunakan.
2. VAS adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual tingkat nyeri pasien dari rentang 0-10 yang diwakili oleh garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimernya.
3. VRS adalah skala yang menggunakan angka-angka 0 sampai 10 untuk menggambarkan tingkat nyeri. Dua ujung ekstrem juga digunakan pada skala ini, sama seperti pada VAS. Skala numerik verbal ini lebih bermanfaat pada periode pascabedah, karena secara alami verbal/kata-kata tidak terlalu mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal menggunakan kata-kata dan bukan

garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri. Skala yang digunakan dapat berupa tidak ada nyeri, sedang, parah.

F. Pengelolaan Nyeri pada Penyakit Terminal

Nyeri yang dirasakan pasien biasanya sangat mengganggu sehingga pasien berupaya untuk mengatasi nyerinya. Berbagai upaya dapat dilakukan baik secara farmakologi maupun non farmakologi (Astutik & Yanto, 2023). Tujuan pengelolaan atau penanganan nyeri adalah mengurangi Intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang persisten, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri, meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penanganan nyeri secara farmakologi biasanya dilakukan dengan mengonsumsi obat anti nyeri diantaranya a) NSAID (Non Steroid Imflammatory Drugs) digunakan sebagai analgesia nyeri dengan derajat ringan sampai sedang. Obat-obatan ini memiliki ceiling effect, yaitu suatu keadaan/dosis dimana peningkatan dosis lebih lanjut tidak akan lagi menambah efek analgesianya, dan b) obat analgetik yang mengandung narkotik maupun yang non narkotik. Tentunya obat-obatan ini selalu diresepkan oleh dokter agar dosisnya sesuai dengan kondisi pasien.

Penanganan nyeri secara non farmakologi saat ini sudah banyak diteliti dan dipublikasikan namun penerapannya masih kurang. Penanganan nyeri non farmakologi diantaranya distraksi, relaksasi, imajinasi, stimulus kulit dan Anticipatory Guidance (Ilham Fajri, 2022); (Putri, 2022).

G. Pengelolaan Nyeri Non Farmakologi

Penanganan nyeri secara non farmakologi diantaranya distraksi, relaksasi, imajinasi, stimulus kulit dan *Anticipatory Guidance*.

1. Distraksi

Pengalihan perhatian pasien kepada hal-hal yang dapat mengurangi nyeri.

- a. Distraksi visual dapat dilakukan melalui visual seperti melihat pertandingan, menonton televisi, membaca koran, melihat pemandangan dan gambar
- b. Distraksi intelektual dapat dilakukan dengan cara mengisi teka-teki silang, bermain kartu, melakukan kegemaran (di tempat tidur) seperti mengumpulkan perangko, menulis cerita.
- c. Distraksi pendengaran dapat dilakukan dengan mendengarkan musik yang disukai atau suara burung serta gemericik air, individu dianjurkan untuk

memilih musik yang disukai dan musik tenang seperti musik klasik, dan diminta untuk berkonsentrasi pada lirik dan irama lagu. Klien juga diperbolehkan untuk menggerakkan tubuh mengikuti irama lagu seperti bergoyang, mengetukkan jari atau kaki, mendengarkan murotal Al-Qur'an dan mendengarkan music klasik Mozart (Ferry, 2023).

- d. Distraksi pernafasan dapat dilakukan dengan bernafas ritmik, atau bernafas ritmik
2. Relaksasi yang dilakukan yang harus di perhatikan adalah posisi pasien yang tepat, pikiran rileks dan lingkungan yang tenang
3. Massage/Pijatan tujuannya untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis, mengkaji kondisi kulit, meningkatkan sirkulasi/peredaran darah pada area yang dimassase.
4. Stimulus Kulit Teknik dilakukan untuk menstimulasi permukaan kulit agar mengontrol nyeri. Stimulasi kutaneus merangsang serabut-serabut, saat impuls yang dibawa oleh serabut A-Beta mendominasi maka mekanisme gerbang akan menutup sehingga impuls saraf perifer untuk mengirimkan impuls melalui dorsal horn pada medulla spinalis nyeri tidak di hantarkan ke otak. Contoh : mandi air hangat/sauna, massage, kompres air dingin atau panas (Santie, 2024), pijatan dengan menthol, atau TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*) (N Nuraeni, 2020).
5. *Guidance Imaginary* merupakan teknik ini menggunakan imajinasi terarah untuk mengarahkan pikiran ke tempat dan kejadian yang menyenangkan sehingga dapat mencapai relaksasi, membantu menurunkan rasa nyeri pasca operasi, pasien pasca serangan jantung, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi efek negative kemoterapi seperti: Mual, muntah, kecemasan, depresi dan membantu menurunkan nyeri pada pasien kanker payudara.
6. Akupresur merupakan teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok. mirip dengan akupunktur, tetapi tidak menggunakan jarum. Akupresur diduga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta membuat tubuh menjadi rileks. Akupresur dilakukan dengan cara memberikan tekanan di bagian tubuh tertentu menggunakan siku, tangan, atau alat bantu khusus, tetapi tidak menggunakan

jarum (Revianti, 2021). Oleh karena itu, akupresur sering dinamakan akupunktur tanpa jarum.

H. Penutup

Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dirasakan oleh pasien dengan penyakit terminal. Sehingga perlu penanganan dan pengelolaan yang baik dengan tujuan untuk meringankan nyeri yang dirasakan sehingga pasien dapat tetap berkualitas hidupnya. Pengelolaan nyeri dapat dilakukan secara farmakologi maupun non farmakologi.

Referensi

- Astutik, S. &. (2023). Manajemen Nyeri pada pasien cephalgia menggunakan terapi relaksasi otot progresif. *Ners Muda*.
- AMA. (2010). Modul 1 Pain Management: Pathophysiology of pain assesment.
- Bare, S. &. (2002). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. In B. &. Suddart. Jakarta: EGC.
- Ferry, A. N. (2023). Pengaruh terapi Musik Mozart pada pasien yang mengalami nyeri akut pasca operasi fraktur ekstremitas bawah. *Jurnal Keperawatan Budna Delima*.
- Ilham Fajri, D. N. (2022). Terapi non farmakologi dalam mengurangi tingkat nyeri pada pasien kanker payudara stadium 2; literaur review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia*.
- N Nuraeni, A. K. (2020). Enchancing TENS Capability For ApplianceControl And Reduce Confinement Pain 1st Stage. *Jurnal Kebidanan dan keperawatan Aisyiyah*.
- Putri, P. &. (2022). Self Management Nyeri pasien kanker dengan metode non farmakologi. *abdikemas*, 52-56.
- PPNI, T. P. (2018). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia*. Jakarta: DPP PPNI.
- Revianti, I. &. (2021). Teknik Akupresur Titik Hegu (L14) menurunkan intensitas nyeri dismenore pada remaja. *Holistic Nursing Care Approach*.
- Santie, F. &. (2024). Penurunan nyeri leher dengan terapi kompres hangat pada pasien penyakit ginjal kronis yang mengalami hipertensi. *Ners Muda*.
- WHO. (2018). *Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescense*. Retrieved from ncbi.
- Yudiyanto, N. K. (2015). Assessment Nyeri. *CDK*.

BAB V

EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG PERAWATAN PALIATIF DI RUMAH.

A. Pendahuluan

Pengetahuan keluarga dalam perawatan pasien paliatif sangat penting untuk memastikan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit terminal atau kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan. Pasien paliatif memerlukan pendekatan khusus yang fokus pada pengelolaan gejala, pengurangan penderitaan, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka sering menghadapi gejala fisik, emosional, dan psikologis yang kompleks. Keluarga berperan penting dalam mendukung pasien melalui proses ini, sehingga pengetahuan mereka tentang perawatan paliatif menjadi sangat krusial. Keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional tetapi juga terlibat dalam perawatan sehari-hari. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang perawatan paliatif, mereka mungkin tidak mengetahui cara terbaik untuk mengelola gejala atau memberikan dukungan yang diperlukan (Triatmi Dyah Wahyuning, 2018). Keluarga yang teredukasi dapat lebih efektif dalam mengelola gejala seperti nyeri, mual, atau kesulitan bernapas, menyediakan dukungan emosional dan psikologis untuk pasien, membantu pasien dalam membuat keputusan mengenai perawatan dan keinginan mereka di akhir hayat.

Pengetahuan keluarga yang baik berkontribusi pada pengelolaan gejala yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Keluarga yang memahami aspek paliatif dapat lebih peka terhadap kebutuhan pasien dan memberikan perawatan yang lebih tepat sasaran, baik di rumah maupun di fasilitas perawatan. Perawatan paliatif seringkali menuntut banyak dari keluarga, baik dari segi fisik maupun emosional. Pendidikan tentang perawatan paliatif dapat membantu keluarga merasa lebih siap dan mengurangi tingkat stres mereka. Pengetahuan yang baik tentang apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengatasi tantangan dapat membantu keluarga merasa lebih percaya diri dan kurang tertekan (Aisyah, 2020). Keluarga yang teredukasi dapat berkomunikasi lebih efektif dengan tim medis dan terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan pasien. Mereka dapat lebih baik memahami tujuan perawatan, manfaat, dan potensi efek samping dari berbagai intervensi, serta membantu pasien dalam mengungkapkan keinginan mereka.

Edukasi perawatan paliatif bagi keluarga bertujuan memberikan informasi kepada pasien dan anggota keluarga lain tentang perawatan yang dapat dilakukan untuk pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Edukasi ini juga

membantu pasien dan keluarga untuk mengatasi gejala yang mengganggu dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Puspitasari et al., 2020).

B. Perawatan Paliatif Dan Keluarga

Paliatif merupakan penyakit yang bersifat kronis dan terminal. (nd, 2014) dan merupakan penyakit yang sulit disembuhkan atau pada stadium lanjut. Lamanya perawatan, kondisi yang tidak stabil pasien, terbatasnya hubungan sosial dan kesulitan finansial dan dampak negatif terhadap kesehatan fisik anggota keluarga menjadikan beban perawatan dalam keluarga. (Nurmalisyah, F. F. (2018). menjelaskan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi beban merawat keluarga pasien antara lain : kemampuan finansial status pernikahan, lama perawatan, Pendidikan dan pekerjaan menjadi beban keluarga merupakan reaksi psikologis negatif anggota keluarga seperti kesedihan, perasaan kehilangan, perasaan malu dan kecemasan hal tersebut disebabkan oleh karena perubahan hubungan saat perawatan anggota keluarga yang sakit. beban keluarga merupakan suatu kondisi tekanan, masalah, atau suatu kesulitan anggota keluarga saat anggota keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. juga menjelaskan bahwa keluarga sering menyampaikan keluhan emosional dan fisik selama masa pengasuhan anggota keluarga yang sakit.

Perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, selain itu juga melalui pengurangan nyeri, dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien maupun keluarga. Perawatan ini juga menyediakan sistem pendukung untuk menolong keluarga pasien dalam menghadapi kematian dari anggota keluarga yang dicintai sampai dengan masa berkabung. Upaya peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien paliatif perlu ditingkatkan, sebagian besar keluarga mengalami hambatan dalam perawatan salah satunya adalah karena kurang pengetahuan dan pemahaman tentang cara perawatan.

Perawatan paliatif merupakan perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, selain itu juga melalui pengurangan nyeri, dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien maupun keluarga. Perawatan ini juga menyediakan sistem pendukung untuk menolong keluarga pasien dalam menghadapi kematian dari anggota keluarga yang dicintai sampai dengan masa berkabung (Alkhudairi, 2019). Perawatan paliatif akan dapat mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, serta memberikan dukungan kepada pasien serta keluarganya. Jadi, tujuan utama perawatan paliatif adalah bukan untuk menyembuhkan penyakit,

tetapi lebih pada peningkatan kualitas hidup serta yang ditangani pada perawatan paliatif tidak hanya pasien, melainkan juga keluarganya (Emilia, S, 2020). Meski pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal, pasien sudah siap secara psikologis dan spiritual, dan tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Ketika menghadapi fase akhir hayat, diharapkan pasien akan mendapatkan kondisi *die in dignity* (*husnul khotimah*).

Perawatan paliatif termasuk salah satu upaya pencegahan dan pengurangan rasa sakit atau pun masalah lain, meliputi fisik, psikososial atau spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis beserta keluarga melalui identifikasi dini dan pengobatan (World Health Organization 2020).

Perawatan paliatif saat ini menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan. Perawatan paliatif adalah suatu layanan kesehatan yang ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menjalani penyakit yang sulit untuk disembuhkan (Cemy, 2012). Perawatan paliatif merupakan bagian dari penanganan penyakit tidak menular diantaranya penyakit kanker, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes melitus dan penyakit lainnya yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan keluarga (Permenkes, 2017).

Kualitas hidup merupakan target yang ingin dicapai pada perawatan paliatif. Kualitas hidup pasien adalah keadaan pasien yang dipersepsikan sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya, termasuk tujuan hidup, harapan dan niatnya. Dimensi dari kualitas hidup adalah kemampuan fisik dan fungsional dalam beraktivitas, kesejahteraan keluarga, ketenangan spiritual, fungsi sosial, kepuasan terhadap pengobatan (termasuk masalah keuangan), orientasi masa depan, kehidupan seksual, termasuk gambaran terhadap diri sendiri dan fungsi dalam bekerja. Sebagian Keluarga dengan pasien paliatif kurang paham dengan perawatan paliatif, hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi mengenai paliatif care. Kurangnya pengetahuan keluarga juga berpengaruh kepada dukungan keluarga ke pasien paliatif. Pengetahuan keluarga tentang penyakit dan penatalaksanaan penyakit paliatif diperlukan oleh keluarga. (Liberty, 2019).

Prinsip-prinsip perawatan paliatif adalah menghargai setiap kehidupan, menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu, serta mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual dalam perawatan pasien dan keluarga, menghindari tindakan medis yang sia-sia, memberikan dukungan yang diperlukan agar pasien tetap aktif sesuai dengan kondisinya sampai akhir hayat, serta memberikan dukungan kepada keluarga dalam masa duka cita (Kahveci, 2014).

Kegiatan pendampingan keluarga paliatif perlu dilakukan salah satunya untuk membantu keluarga memberikan pengetahuan dalam merawat anggota keluarga yang sakit. (Shanmugasundaram, 2014) beberapa anggota keluarga paliatif tidak

mengetahui tentang perawatan pasien paliatif. (Kahveci, 2014) beberapa keluarga paliatif tak mengetahui tentang paliatif dan keluarga berinisiatif secara mandiri untuk mendapatkan informasi tersebut dari keluarga dan teman dekat. (Alkhudairi, 2019) kurangnya pengetahuan mempengaruhi tingkat kesadaran, pemahaman yang buruk tentang perawatan paliatif. Peran keluarga bagi pasien paliatif sangatlah penting. Pengetahuan mengenai kebutuhan dan keterampilan keluarga untuk dukungan dalam perawatan masih terbatas.

C. Edukasi Dalam Perawatan Paliatif

Edukasi dalam perawatan paliatif adalah upaya untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan paliatif. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, penyusunan jadwal kunjungan, dan penyusunan program paliatif. Pemahaman dan penerapan perawatan paliatif yang tepat menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka di saat-saat akhir kehidupan. Namun, pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan perawatan paliatif masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Banyak tenaga kesehatan kurang mendapatkan pelatihan yang memadai dalam perawatan paliatif, sehingga kadangkala pasien tidak mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka (Lam, 2019). Perawatan paliatif merupakan suatu pendekatan perawatan yang holistik, ditujukan untuk meredakan penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami penyakit kronis atau terminal.

Pengembangan Program Edukasi Perawatan Paliatif dilakukan untuk meningkatkan kognitif peserta dari yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui tentang Pengembangan Program Edukasi Perawatan Paliatif.

1. Pengenalan tentang perawatan paliatif
2. Tujuan dan manfaat dari program edukasi perawatan paliatif di panti werda
3. Prinsip Perawatan Paliatif
4. Pengetahuan Dasar tentang Penyakit Kronis
5. Manajemen Gejala dan Dukungan Psikososial
6. Keterampilan komunikasi
7. Aspek Etis dalam Perawatan Paliatif
8. Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan melakukan praktik

1. Penyusunan dan implementasi program edukasi yang relevan dan efektif untuk tenaga kesehatan
2. Strategi untuk mempromosikan kesadaran dan penerapan praktik perawatan paliatif di tempat kerja

3. Evaluasi efektivitas program edukasi perawatan paliatif yang telah diimplementasikan
4. Identifikasi area perbaikan dan pengembangan lanjutan

Metode edukasi yang fleksibel dapat memberikan kemudahan akses bagi perawat terhadap peningkatan pendidikan dan kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan penerapan

keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik profesional, hubungan interpersonal, dan evaluasi (Church, 2016). Beberapa intervensi edukasi yang dapat diterapkan, diantaranya metode ceramah, workshop, multimedia dan simulasi. Metode edukasi yang ideal harus mempertimbangkan kemampuan peserta dan materi yang disampaikan. Tujuan dari edukasi harus dapat dicapai secara jelas dan terukur (Latta & MacLeod, 2019).

Pembelajaran ceramah merupakan model pembelajaran yang konvensional, yaitu berupaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik yang mempertemukan guru dengan siswa dalam suatu ruangan untuk belajar yang memiliki karakteristik yang terencana, yang berorientasi pada tempat (place-based) dan interaksi sosial (Sureskiarti et al., 2020). Tenaga kesehatan yang berorientasi pada perawatan paliatif harus memiliki sikap peduli terhadap pasien (empati), menganggap pasien sebagai seorang individu yang unik, serta harus mempertimbangkan faktor lain seperti etnis, ras, agama, dan faktor budaya lain yang bisa mempengaruhi penderitaan pasien (Triatmi, 2018). Persetujuan dari pasien dan atau keluarganya adalah mutlak diperlukan sebelum perawatan dimulai. Pasien dapat memilih tempat dilakukannya perawatan. Jika ada seorang pasien dalam kondisi terminal menginginkan untuk diberikan perawatan di rumah, maka perawatan paliatif ini dapat dilakukan melalui perawatan rumah (home care).

Edukasi adalah proses pembelajaran yang berujung untuk mengembangkan potensi individu dalam hal pengetahuan keterampilan, sikap, dan lain-lain. Dengan adanya edukasi, seseorang diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Tujuan Edukasi

1. Meningkatkan kecerdasan
2. Mengubah kepribadian manusia
3. Menjadikan seseorang mampu mengontrol diri
4. Meningkatkan keterampilan
5. Bertambahnya kreativitas
6. Mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuni

Manfaat Edukasi

1. Meningkatkan pengetahuan
2. Mengasah keterampilan
3. Meningkatkan peluang karier
4. Mendorong perkembangan kepribadian
5. Mengembangkan potensi diri
6. Mengerjakan passion atau minat

Jenis Edukasi

1. Pendidikan formal
2. Pendidikan non-formal
3. Pendidikan informal
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Pendidikan khusus
6. Pendidikan vokasi
7. Pendidikan orang dewasa
8. Pendidikan jarak jauh dan online

Tujuan edukasi atau pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan suatu kaum., tujuan edukasi atau pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia menjadi insan yang beriman serta berbudi pekerti luhur. Edukasi memungkinkan seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang matang, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab dan berbangsa dan bernegara.

Pasien paliatif memerlukan pendekatan khusus yang fokus pada pengelolaan gejala, pengurangan penderitaan, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka sering menghadapi gejala fisik, emosional, dan psikologis yang kompleks. Keluarga berperan penting dalam mendukung pasien melalui proses ini, sehingga pengetahuan mereka tentang perawatan paliatif menjadi sangat krusial. Keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional tetapi juga terlibat dalam perawatan sehari-hari. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang perawatan paliatif, mereka mungkin tidak mengetahui cara terbaik untuk mengelola gejala atau memberikan dukungan yang diperlukan. Keluarga yang teredukasi dapat lebih efektif dalam Mengelola gejala seperti nyeri, mual, atau kesulitan bernapas, menyediakan dukungan emosional dan psikologis untuk pasien, membantu pasien dalam membuat keputusan mengenai perawatan dan keinginan mereka di akhir hayat.

Pengetahuan keluarga yang baik berkontribusi pada pengelolaan gejala yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Keluarga yang

memahami aspek paliatif dapat lebih peka terhadap kebutuhan pasien dan memberikan perawatan yang lebih tepat sasaran, baik di rumah maupun di fasilitas perawatan. Perawatan paliatif seringkali menuntut banyak dari keluarga, baik dari segi fisik maupun emosional. Pendidikan tentang perawatan paliatif dapat membantu keluarga merasa lebih siap dan mengurangi tingkat stres mereka. Pengetahuan yang baik tentang apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengatasi tantangan dapat membantu keluarga merasa lebih percaya diri dan kurang tertekan. Keluarga yang teredukasi dapat berkomunikasi lebih efektif dengan tim medis dan terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan pasien. Mereka dapat lebih baik memahami tujuan perawatan, manfaat, dan potensi efek samping dari berbagai intervensi, serta membantu pasien dalam mengungkapkan keinginan mereka.

D. Penutup

Edukasi pasien dan keluarga pada perawatan paliatif sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keterampilan keluarga. Edukasi yang baik akan mampu meningkatkan pengetahuan yang tepat, keluarga dapat lebih efektif dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawatan paliatif tidak hanya tentang aspek fisik tetapi juga dukungan emosional. Edukasi dapat membantu keluarga mengatasi tantangan psikologis dan emosional. Pasien akan lebih optimal dalam menjalani perawatannya. Edukasi yang menerapkan Komunikasi yang baik adalah kunci untuk perawatan paliatif yang efektif. Peningkatan dalam komunikasi saat dilaksanakan edukasi dapat mengarah pada keputusan perawatan yang lebih baik dan pengalaman perawatan yang lebih memuaskan bagi pasien dan keluarga.

Tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas. Dengan edukasi yang diberikan pasien dan keluarga diharapkan meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang membutuhkan perawatan paliatif. Keluarga kini lebih memahami konsep perawatan paliatif, termasuk aspek-aspek seperti manajemen nyeri, kontrol gejala, dan dukungan emosional. Kegiatan ini juga membantu mengurangi stigma yang mungkin ada terkait perawatan paliatif dan mengatasi ketidakpastian yang sering dirasakan oleh keluarga. Pengetahuan yang lebih baik memungkinkan keluarga merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan perawatan.

Peningkatan pengetahuan, keluarga dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien meskipun dalam fase akhir penyakit. Program ini menunjukkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam perawatan paliatif dan bagaimana pendidikan dapat memperkuat peran mereka. Keluarga yang teredukasi dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan.

Meski pengetahuan keluarga meningkat, masih terdapat kebutuhan untuk dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk pendidikan lanjutan, bimbingan, maupun akses ke sumber daya dan layanan profesional untuk memastikan perawatan paliatif yang efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat yang fokus pada peningkatan pengetahuan keluarga dalam perawatan paliatif memberikan dampak positif bagi kualitas perawatan dan kesejahteraan pasien serta keluarga, sekaligus menyoroti perlunya dukungan yang berkelanjutan dalam perawatan paliatif.

Referensi

- Anti, A. (2020). Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan perawat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*
Sandi Husada, 11(1), 456–460. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.321>
- Alkhudairi, H. M. (2019). General Public Awareness, Knowledge And Beliefs Toward Palliative Care In A Saudi Population. *Journal Of Nature And Science Of Medicine*
| Volume 2, 48-53.
- nd, (2014). *Pedoman Nasional Program Paliatif Kanker*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Aisyah Dzil Kamalah, A. K. (2020). Efektivitas Psikoedukasi Keluarga Dalam Menurunkan Bebankeluarga Pada Keluarga Pasien Ulkus Diabetes Melitus. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, Volume 3 No 1, Hal 9 – 16, Februari 2020 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah.
- Church, C. D. (2016). Defining Competence in Nursing and Its Relevance to Quality Care. *Journal for Nurses in Professional Development*, 32(5), E9–E14.
<https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000289>
- Emilia, S. (2020). Beban Keluarga Merawat Pasien Paliatif: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, Volume 12 No 4, Hal 927 .
- Kahveci, K. &. (2014). Knowledge About Palliative Care In The Families Of Patients. . *Acta Medica Mediteranea*,, 30: 1099.
- Latta, L., & MacLeod, R. D. (2019). *Palliative Care Education: An Overview* BT - *Textbook of Palliative*
- Lam, C. G., Howard, S. C., Bouffet, E., & Pritchard-Jones, K. (2019). Science and health for all children with cancer. *Science*, 363(6432), 1182–1186.
<https://doi.org/10.1126/science.aaw4892>
- Liberty Oktoriati Zendrato¹, L. R. (2019). Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Perawatan Paliatif Disatu Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Barat. *Nursing Current*, Vol. 7 No.2.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- Puspitasari, S. (2020). Gambaran Beban Caregiver Keluarga Pada Pasien Kanker Dirumah Singgah Yayasan Kanker. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurmalisyah, F. F. (2018). Pengaruh Psiko Edukasi Keluarga Terhadap Beban Keluarga Dan Dukungan Keluarga Pasien Skizofrenia Di Rumah. Surabaya: Universitas Erlangga.
- Shanmugasundaram, S. (2014). Knowledge Of Palliative Acre: An Indian's Perspective. *Nursing And Health* Doi: 10.13189/Nh.2014.020502, 2(5): 100-105.

- Sureskiarti, E., Masnina, R., Wijayanti, T., & Zulaikha, F. (2020). Workshop Sosialisasi Komunikasi S.B.a.R Pada Perawat. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 407–412.
- Triatmi Dyah Wahyuning, A. H. (2018;). Impact Of Brief Interactive Psycho-Education Interventionon Caregiver Toward Family Care Burden For Schizophrenic Patients At Puskesmas Kasihan Ii, Bantul. Rev Prim Care Prac And Educ. , 1(1): 37-43.
- Triatmi Dyah Wahyuning, A. H. (2018;). Impact Of Brief Interactive Psycho-Education Interventionon Caregiver Toward Family Care Burden For Schizophrenic Patients At Puskesmas Kasihan Ii, Bantul. Rev Prim Care Prac And Educ. , 1(1): 37-43.
- World Health Organization, W. (2020a). Global Atlas of Palliative Care 2nd Edition (p. 119). Worldwide Palliative Care Alliance.

Glosarium

Agitasi	: Perasaan jengkel, gelisah atau cemas
Anaplasia	: Struktur sel dewasa berubah menjadi sel yang lebih primitive
Ansietas	: Perasaan tidak nyaman dan khawatir, biasanya digeneralisasikan dan tidak fokus sebagai reaksi berlebihan terhadap situasi yang secara subyektif dilihat sebagai ancaman. Ketakutan berlebihan atau bertahan melampaui periode normalnya. Hal ini berbeda dari ketakutan atau kecemasan sementara, seringkali dipicu oleh stres, dan berlangsung lebih lama (misalnya, biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih).
Caregiver	: Seseorang yang telah lulus pendidikan atau pelatihan untuk melakukan pendampingan pada seseorang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan karena keterbatasan fisik atau mental
Depresi	: Suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental
Edukasi Perawatan	: Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
Paliatif	: Profesional kesehatan dalam memberikan perawatan paliatif kepada pasien
Hospice	: Fasilitas atau program yang menyediakan perawatan paliatif bagi pasien yang memasuki fase akhir penyakit terminal mereka.
Organisasi Kesehatan	: Badan kesehatan dunia yang merupakan bagian dari Perserikatan
Dunia (WHO)	: Bangsa-Bangsa (PBB) dan bertanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan global.
Paliatif	: Pelayanan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif, atau tidak dapat disembuhkan secara medis.(stadium akhir)

Penyakit terminal : Penyakit yang tidak dapat diobati atau disembuhkan yang dapat mengakibatkan kematian pada penderitanya

Perawat : Suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi

Perawatan Paliatif : Pendekatan medis yang bertujuan untuk meringankan penderitaan fisik, emosional, spiritual, dan psikologis pasien yang menghadapi penyakit serius, kronis, atau terminal, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup.

Psikologis : Suatu keadaan atau kondisi dari hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera, seperti isi pikiran, perasaan, pengetahuan dan lain-lain

Profil Penulis



Neni Nuraeni, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Mat., Lahir di Bandung, 21 April 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran pada tahun 1995. S2 pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2008. Dan Program Spesialis Keperawatan Maternitas di Fakultas Ilmu Keperawatan pada Universitas Indonesia pada tahun 2010. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sejak tahun 2001. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu pada bidang Pendidikan mengajar pada mata kuliah keperawatan maternitas, gadar focus maternitas dan palliative care. Pada bidang penelitian dan publikasi juga aktif dalam penelitian dan publikasi artikel, pengelola jurnal Tingkat nasional, narasumber seminar, penulis buku. Dan saat ini diberi amanah tugas dosen tambahan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya periode 2023-2027. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: neni.nuraeni@umtas.ac.id



Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D Lahir di Yogyakarta, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Bethesda Yakkum Yogyakarta pada 1999. S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Charles Darwin University dan Flinders University, Australia di tahun 2010 dan 2013. Stud S3 diselesaikan pada 2023 di Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta sejak tahun 2003. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi artikel, pengelola jurnal (nasional/internasional), reviewer jurnal (nasional/internasional), ketua LPPM, narasumber seminar/pelatihan, penulis buku, serta *founder* untuk BerCa.my.id, sebuah *website* untuk dukungan *bereavement* secara virtual. Karya ilmiah penulis banyak berhubungan dengan perawatan paliatif, khususnya *bereavement care*, menggunakan berbagai pendekatan penelitian seperti kualitatif, *literature review*, dan meta-analysis. Penulis juga aktif sebagai pengurus himpunan perawat onkologi (HIMPONI) dan perawat paliatif (INPANA). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yeni@stikesbethesda.ac.id



Lam Murni Br Sagala, S.Kep.,Ns.,M.Kep Dosen Program Studi Profesi Ners Universitas Murni Teguh Penulis lahir Lahir di Kabanjahe, pada tanggal 02 April 1987, anak pertama dari dari pasangan Bapak B. Sagala dengan Ibu D.br Sitanggang. Riwayat pendidikan telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Keperawatan di Program studi DIII Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) Pada tahun 2008. Setelah selesai dari Diploma 3 Keperawatan langsung melanjutkan studi pendidikan Sarjana Keperawatan dan Program Pendidikan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2008-2010. Selanjutnya Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Magister Keperawatan - Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU) dan selesai pada Tahun 2016. Pengalaman kerja di beberapa institusi kesehatan seperti di Akademi Keperawatan Darmo Medan sebagai sebagai Pembantu Direktur I Bidang Akademik tahun 2014 - 2018 dan STIKes Murni Teguh sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tahun 2018-2021, sebagai Wakil Ketua IV Bidang Kerja sama dan Pengembangan tahun 2021-2023. Saat STIKes Murni Teguh berubah bentuk menjadi Universitas Murni Teguh sebagai Ka. Biro Kerja Sama tahun 2023- sekarang. Penulis memiliki kepakaran dibidang Asuhan Keperawatan Medikal Bedah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dan menulis buku di bidang keperawatan medical bedah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Kemenristek DIKTI.

Email Penulis : lammurnisagala@gmail.com,

Motto: "Living your life well"



Ns. Ratna Aryani, M.Kep Lahir di Jakarta, 16 April. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi keperawatan, Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan saat ini sedang menempuh program S3 di Universitas yang sama. Riwayat pekerjaan diawali di RS pemerintah, perusahaan minyak dan juga asisten peneliti keperawatan. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai dosen mengampu mata kuliah keperawatan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, narasumber pelatihan/seminar/workshop, perawat luka & stoma juga sebagai relawan di komunitas KOIN (Komunitas Ostomate Indonesia). Adapun penulis juga pernah meraih beberapa kompetisi sebagai 10 besar Dosen Berprestasi Nasional (2020), Juara 2 kompetisi Nasional menulis essay, dan penerima beberapa beasiswa (Temasek foundation, JICA foundation, WCET foundation, BPPSDM, PPA dan Golongan Karya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ratna_aryani@poltekkesjakarta1.ac.id **Motto: "Just do your best"**



Yuliati.,SKp.,MM.,M.Kep. Lahir di Jakarta, 01 Juli 1969, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada AKPER DEPKES RI JAKARTA tahun 1989, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (PSIK) pada tahun 1997, lalu melanjutkan Program S2 Manajemen Sumber daya Manusia di Institute Magister Manajemen Indonesia (IMMI) pada tahun 2002. Selanjutnya menempuh program S2 bidang Keperawatan di Universitas Indonesia tahun 2015. Saat ini sedang menempuh pendidikan program DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MEDICAL SCIENCE (S3) Di University Malaysia Sabah Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 di RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina/ Ruang Perawatan Khusus sebagai Clinical Instruktur di Bagian ICU, ICCU, HD dan IGD). Tahun 2006 mutasi ke Bagian Manajemen mutu sebagai Kepala Standarisasi RS. Penulis juga tercatat sebagai Koordinator Audit Mutu Internal Rumah sakit sejak 2008 sampai tahun 2012. Lalu tahun 2012 Penulis mutasi ke Universitas Esa Unggul Sebagai Dosen. Penulis juga bekerja di RS Grand family Pluit Jakarta tahun 2016 – 2020). Penulis juga tercatat sebagai surveior penilai akreditasi rumah sakit di Lembaga Akreditasi Mutu - Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS). Pengalaman organisasi, saat ini aktif sebagai pengurus organisasi DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia yakni Anggota Bidang Diklat, Organisasi HPHI (Himpuna Perawat Holistik Indonesia) Bidang Organisasi, Organisasi Komunitas Relawan Emergensi Indonesia (KREKI) bidang kurikulum, Instruktur Pelatihan di Medikal Service & Training 119 dan penulis juga menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SMAN 7 Jakarta Sejak 2021 sampai Sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Esa Unggul Program Studi Keperawatan mengampu mata kuliah Paliatif, Keperawatan Komplementer, Kegawatdaruratan dan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Narasumber pelatihan Kegawatdaruratan,dan Bencana, Keperawatan Holistik/ Komplementer dan Manajemen. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yuliati@esaunggul.ac.id.

Sinopsis Buku

Buku Manajemen Keperawatan dalam Perawatan Paliatif merupakan referensi penting bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan praktik perawatan paliatif secara profesional dan holistik. Perawatan paliatif tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik pasien, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, psikologis, sosial, dan spiritual baik bagi pasien maupun keluarganya.

Buku ini menyajikan lima topik utama yang saling berkaitan. Dimulai dengan pembahasan tentang peran keperawatan dalam memberikan perawatan paliatif, pembaca diajak memahami bagaimana perawat menjadi garda depan dalam mendampingi pasien dengan penyakit terminal. Kemudian, buku ini mengulas pendekatan komunikasi yang efektif, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan yang penuh empati dan kepercayaan dengan pasien dan keluarga.

Selanjutnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang dukungan psikologis bagi keluarga pasien, sebuah aspek yang sering terlupakan namun sangat penting dalam perawatan paliatif. Buku ini juga mengupas secara mendalam strategi pengelolaan nyeri, salah satu tantangan utama dalam praktik paliatif. Akhirnya, buku ini menutup dengan topik edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan paliatif di rumah, guna mendukung keberlangsungan perawatan yang manusiawi dan berkelanjutan.

Disusun dengan pendekatan berbasis praktik dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan aplikatif dan relevan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan paliatif di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Buku Manajemen Keperawatan dalam Perawatan Paliatif merupakan referensi penting bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan praktik perawatan paliatif secara profesional dan holistik. Perawatan paliatif tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik pasien, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, psikologis, sosial, dan spiritual baik bagi pasien maupun keluarganya.

Buku ini menyajikan lima topik utama yang saling berkaitan. Dimulai dengan pembahasan tentang peran keperawatan dalam memberikan perawatan paliatif, pembaca diajak memahami bagaimana perawat menjadi garda depan dalam mendampingi pasien dengan penyakit terminal. Kemudian, buku ini mengulas pendekatan komunikasi yang efektif, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan yang penuh empati dan kepercayaan dengan pasien dan keluarga.

Selanjutnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang dukungan psikologis bagi keluarga pasien, sebuah aspek yang sering terlupakan namun sangat penting dalam perawatan paliatif. Buku ini juga mengupas secara mendalam strategi pengelolaan nyeri, salah satu tantangan utama dalam praktik paliatif. Akhirnya, buku ini menutup dengan topik edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan paliatif di rumah, guna mendukung keberlangsungan perawatan yang manusiawi dan berkelanjutan.

Disusun dengan pendekatan berbasis praktik dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan aplikatif dan relevan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan paliatif di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

